Inhaltsverzeichnis

Kostenlose FSP-/FaMed-Webinare 1
Kostenloser Vorbereitungskurs 1
Grammatik 5
- Adjektive / Adverbien 5
  - Unterschied Adjektiv / Adverb 5
  - Deklination von Adjektiven 5
- N-Deklination von Nomen 8
- Indirekte Rede 9
  - Formen der indirekten Rede 10
  - Konjunktiv-Regeln für die indirekte Rede 13
  - Übungen 14
  - Regel-Tabelle 16

Arzt-Patienten-Gespräch 19
- Struktur des Arzt-Patienten-Gesprächs 19
  - 1. Allgemeine Informationen 19
  - 2. Beschwerden 21
  - 3. Vegetative Anamnese 29
  - 4. Vorerkrankungen & Vor-OPs 31
  - 5. Medikamente 32
  - 6. Allergien & Unverträglichkeiten 33
  - 7. Noxen 33
  - 8. Familienanamnese 34
  - 9. Sozialanamnese 34
  - 10. Nächste Schritte und ggf. Zusammenfassung 35

Dokumentation 36
- Persönliche Info & Hauptbeschwerden 36
  - Zeitangaben 37
- Begleitbeschwerden 37
- Vegetative Anamnese 37
- Vorerkrankungen / Medikamente 38
- Vor-OPs 38
- Allergien & Unverträglichkeiten 38
- Noxen 38
- Familienanamnese 39
- Sozialanamnese 39
- Verdachtsdiagnose 39
- Differentialdiagnosen 39
- Nächste Schritte / Diagnostik 39
- Therapie 40

Arzt-Arzt-Gespräch 40
- Infos aus dem Gespräch / Allgemeine Fragen 40

Definition 40
Klassifikation 41
Risikofaktoren 41
Ätiologie 41
Symptomatik / Differentialdiagnosen 41
Komplikationen 42
Diagnostik 42
Therapie 42
Kontraindikationen 43
Aufklärungen 43
Fachbegriffe / Abkürzungen 43
Empathie & Reaktionen 43
Was bedeutet Empathie? 43
Was du vermeiden solltest… 44
Emotionslose Reaktionen 44
Allgemeine Phrasen 44
Eskalation des Gesprächs 44
“Wäscheleinen-Empathie” 45
…, aber 45
Frage zu “anderem Thema” 45
Häufige Emotionen in der FSP 46
Glück, Freude, Zufriedenheit 46
Dankbarkeit 47
Angst, Nervosität, Sorge, Unsicherheit 49
Traurigkeit, Depression 52
Genervt, Ungeduld, Bosheit, Wut, Zorn 54
Scham, Peinlichkeit 57
Skepsis, Ungläubigkeit, Zweifel, Unsicherheit 59
Leid (emotional, körperlich), Schmerzen, Stress 62

Grammatik

Adjektive / Adverbien

Unterschied Adjektiv / Adverb

Adjektiv: Beschreibt immer ein Substantiv, z.B.:

- “Wir machen eine *schnelle* **Untersuchung**.”
- “Bei uns in der Klinik gibt es *seltene* **Komplikationen**.”
- “Der Patient erlitt einen *plötzlichen* **Herzstillstand**.”

Adverb: Beschreibt Verben oder Adjektive, werden nicht dekliniert z.B.:

- “Die Untersuchung **geht** *schnell*.” → **keine Deklination!**
- “Bei uns in der Klinik **gibt** es *selten* Komplikationen.”
- “Der Patient stellte sich wegen *plötzlich* **eingetretener** Schmerzen vor.”

Deklination von Adjektiven

Die Deklination von Adjektiven wird durch mehrere Faktoren bestimmt:

1. Geschlecht des Nomens (m, f, n)
2. Zahl des Nomens (Singular, Plural)
3. Kasus (Nominativ, Akkusativ, Genitiv, Dativ)
4. *verwendeter Artikel*

Bzgl. der “verwendeten Artikel” unterscheidet man 3 Kategorien:

1. Ohne Artikel

- ganz **ohne Artikel**:
  Ich mag gutes Essen.
- nach **Zahlen im Plural**:
  Ich habe zwei neue Patienten.
- nach "etwas", "viel", "wenig", "mehr", "weniger":
  Ich gehe mit viel neuem Mut in die FSP.

2. Nach unbestimmtem Artikel (ein, eine — sowie Wörter die genauso deklinieren)

- **unbestimmter Artikel**:
  Ein guter Arzt ist empathisch.
- nach **Possessivpronomen** (mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr, Ihr):
  Mein neuer Arzt ist empathisch.
- nach **Negativartikel** "kein":
  Kein deutscher Arzt spricht perfekt Deutsch.
- nach "**irgendein**":
  Das ist irgendein komischer Typ.

3. Nach bestimmtem Artikel (der, die, das, die — sowie Wörter die genauso deklinieren)

- **bestimmter Artikel**:
  Der neue Arzt ist empathisch.
- nach "dieser", "jener", "jeder", "welcher", "mancher", "solcher":
  Jeder gute Arzt kennt das.
- nach "derselbe", "derjenige":
  Das ist derselbe neue Arzt.
- nach "alle":
  Alle guten Dinge sind drei.

Nominativ

ohne Artikel / stark dekliniert	unbestimmter Artikel bzw. “artikelähnliches” / gemischt dekliniert	**bestimmter Artikel / schwach dekliniert**
Gut**er** Rat ist teuer.	Ein gut**er** Arzt ist empathisch.	De**r** gut**e** Arzt ist empathisch.
Gut**e** Sicht ist wichtig.	Ein**e** gut**e** Ärztin ist empathisch.	Di**e** gut**e** Ärztin ist empathisch.
Gut**es** Essen ist lecker.	Ein gut**es** Krankenhaus ist sauber.	Da**s** gut**e** Krankenhaus ist sauber.

Gute Ärztinnen / Ärzte sind empathisch.	Meine guten Patientinnen sind…	Die guten Ärztinnen / Ärzte sind empathsich.

Akkusativ

ohne Artikel / stark dekliniert	unbestimmter Artikel bzw. “artikelähnliches” / gemischt dekliniert	**bestimmter Artikel / schwach dekliniert**
Ich habe guten Rat erhalten.	Ich untersuche einen neuen Patienten. Ich untersuche meinen neuen Patienten.	Ich untersuche den neuen Patienten.
Ich habe gute Sicht.	Ich untersuche eine neue Patientin. Ich untersuche meine neue Patientin.	Ich untersuche die neue Patientin.
Ich mag gutes Essen.	Ich untersuche ein neues Kind. Ich untersuche mein neues Kind.	Ich untersuche das neue Kind.
Ich mag dankbare Patienten.	Ich untersuche meine neuen Patienten.	Ich untersuche die neuen Patienten.

Dativ

ohne Artikel / stark dekliniert	unbestimmter Artikel bzw. “artikelähnliches” / gemischt dekliniert	**bestimmter Artikel / schwach dekliniert**
Ich gehe mit viel neuem Mut in die FSP.	Ich gebe einem neuen Patienten Medikamente. Ich gebe meinem neuen Patienten Medikamente.	Ich gebe dem neuen Patienten Medikamente.
Ich gehe mit wenig neuer Angst in die FSP.	Ich gebe einer neuen Patientin Medikamente. Ich gebe meiner neuen Patientin Medikamente.	Ich gebe der neuen Patientin Medikamente.
Ich gehe mit viel neuem Wissen in die FSP.	Ich gebe einem neuen Kind Medikamente. Ich gebe meinem neuen Kind Medikamente.	Ich gebe dem neuen Kind Medikamente.
Ich gehe mit neuen Klamotten in die FSP.	Ich gebe meinen neuen Patienten Medikamente.	Ich gebe den neuen Kindern Medikamente.

Genitiv

ohne Artikel / stark dekliniert	unbestimmter Artikel bzw. “artikelähnliches” / gemischt dekliniert	**bestimmter Artikel / schwach dekliniert**
Trotz neu**en** Mut**s** konnte ich die Prüfung nicht bestehen.	Die Meinung eine**s** neu**en** Patienten ist mir wichtig.	Die Meinung de**s** neu**en** Patienten ist mir wichtig.
Trotz groß**er** Angst konnte ich die Prüfung bestehen.	Die Meinung eine**r** neu**en** Patientin ist mir wichtig.	Die Meinung de**r** neu**en** Patientin ist mir wichtig.
Trotz schlecht**en** Wetter**s** bin ich spazieren gegangen.	Die Meinung eine**s** neu**en** Kindes ist mir wichtig.	Die Meinung de**s** neu**en** Kindes ist mir wichtig.
Trotz neu**er** Übungen fallen mir Deklinationen noch schwer.	Die Meinung meine**r** neu**en** Patienten ist mir wichtig.	Die Meinung de**r** neu**en** Patienten ist mir wichtig.

Akkusativ:

Der Patient **habe** seit 3 Tagen rezidivierend____ und progredient____ Nachtschweiß. (-en)

Der Patient **habe** seit 3 Tagen rezidivierend____ und progredient____ Dyspnoe. (-e)

Der Patient **habe** seit 3 Tagen rezidivierend____ und progredient____ Nasenbluten. (-es)

Der Patient **habe** seit 3 Tagen rezidivierend____ und progredient____ Schmerzen. (-e)

Dativ:

Der Patient stellte sich **mit** seit 3 Tagen bestehend____, rezidivierend____ und progredient____ Nachtschweiß bei uns vor. (-em)

Der Patient stellte sich **mit** seit 3 Tagen bestehend____, rezidivierend____ und progredient____ Dyspnoe bei uns vor. (-er)

Der Patient stellte sich **mit** seit 3 Tagen bestehend____, rezidivierend____ und progredient____ Nasenbluten bei uns vor. (-em)

Der Patient stellte sich **mit** seit 3 Tagen bestehend____, rezidivierend____ und progredient____ Schmerzen bei uns vor. (-en)

Genitiv:

Der Patient stellte sich **wegen** seit 3 Tagen bestehend____, rezidivierend____ und progredient____ Nachtschweiß**es** bei uns vor. (-en)

Der Patient stellte sich **wegen** seit 3 Tagen bestehend____, rezidivierend____ und progredient____ Dyspnoe bei uns vor. (-er)

Der Patient stellte sich **wegen** seit 3 Tagen bestehend____, rezidivierend____ und progredient____ Nasenbluten**s** bei uns vor. (-en)

Der Patient stellte sich **wegen** seit 3 Tagen bestehend____, rezidivierend____ und progredient____ Schmerzen bei uns vor. (-er)

Sonstiges

Der Patient stellte sich **mit** seit 3 Tagen bestehend____, rezidivierend____ und progredient____ Nachtschweiß und konstant**er** Dyspnoe bei uns vor. (-em)

Der Patient stellte sich mit seit 5 Wochen bestehend**er**, rezidivierend**er** *Dyspnoe* **sowie** (kalt**em**) Nachtschweiß, (konstant**er**) Polyurie und (hoh**em**) Fieber bei uns vor.

Der Patient stellte sich wegen seit 5 Wochen auftretender Hustenattacken **mit** Dyspnoe und Vertigo bei uns vor.

Der Patient stellte sich **mit** *seit* 3 Tagen *bestehenden* Kopfschmerzen bei uns vor. ("seit" mit Partizip I - Adjektiv)

Der Patient stellte sich **mit** *vor* 3 Tagen *aufgetretenen* Kopfschmerzen bei uns vor. ("vor" mit Partizip II - Adjektiv)

Der Patient habe seit 3 Tagen Kopfschmerzen.

~~Der Patient stellte sich seit 3 Tagen **mit** Kopfschmerzen bei uns vor.~~

~~Der Patient stellte sich **mit** seit 3 Tagen Kopfschmerzen bei uns vor.~~

Der Patient stellte sich **infolge** (Genitiv) eines Unfalls/Sturzes/epileptischen Anfalls bei uns vor. Er berichtete von …

N-Deklination von Nomen

N-Deklination ist im Schriftlichen wichtiger als im Mündlichen. Im Mündlichen wird es auch oft "ignoriert" bzw. als Fehler toleriert. Außerdem schränkt es nicht das Verständnis ein.

N-Deklination gibt es ***nur*** bei:

- **maskulinen** Nomen
- Plural endet mit **-en** oder (selten) **-n**

Häufig sind das:

- **Menschen**
- **Berufe**
- Tiere, Nationalitäten, …
- Wörter, die auf -and/-ant/-at/-ent/-ist/-oge enden

Für die FSP sehr relevant sind wenige Wörter… Die wichtigsten:

Der Patient:

- Akk: Ich begrüße den Patient**en**.
- Dat: Ich verschreibe dem Patient**en** ein neues Medikament
- Gen: Die Angaben des Patient**en** sind vertrauenswürdig.
- **Achtung:** Gut Aussprechen, da sonst "Patientin" draus wird

Der Herr:

- Akk: Ich möchte Ihnen Herr**n** Müller vorstellen.
- Dat: Ich verschreibe Herr**n** Müller ein neues Medikament
- (Gen: Die Angaben des Herr**n** Müllers sind vertrauenswürdig.)

Zudem auch die folgenden Wörter:

- Der Neurologe → den Neurologen
- Der Assistent → den Assistenten
- Der Therapeut → den Therapeuten
- Der Nachbar → den Nachbar**n**
- (Der Mensch → den Menschen)
- Der Automat → den Automaten
- Der Parasit → den Parasiten
- …

Es wäre nicht deutsch, wenn es keine Ausnahme gäbe:

das Herz (Pl.: die Herzen)

- Akk: Ich untersuche das Herz.
- Dat: Bei Ihrem Herz**en** gibt es ein Problem.
- Gen: Die Gefäße des Herz**ens** sind verengt.

Indirekte Rede

Indirekte Rede dient dazu, die Äußerungen von Patient:innen wiederzugeben, ohne sie wörtlich zu zitieren. Die Wiedergabe aller Informationen aus der Anamnese muss in der Patientenvorstellung in indirekter Rede erfolgen.

Im Deutschen gibt es verschiedene Möglichkeiten, Informationen in der indirekten Rede wiederzugeben. „Standard“ ist die Verwendung des Konjunktivs. Doch nicht alle Ärztekammern verlangen die durchgängige Verwendung des Konjunktivs in der indirekten Rede. Ersatzweise können Aussagen also auch im Indikativ wiedergegeben werden.

Im Folgenden sind die wichtigsten Formen der indirekten Rede beschrieben:

1. Mit Konjunktiv
2. Mit Inifinitiv
3. Mit Substantiv (ohne Nebensatz)
4. Mit Präpositionen
5. “Mit Indikativ”

Wichtig: Entweder du verwendest 1. - 4. oder 2. - 5. in deiner Patientenvorstellung. 1. und 5. sollten NICHT gemeinsam verwendet / gemischt werden. Das klänge sonst so:

→ Er *trinke (1.)* täglich Bier aber er *raucht (5.)* nicht.

Formen der indirekten Rede

1 - Mit Konjunktiv

Die indirekte Rede mit Konjunktiv ist der Standardfall in der deutschen Sprache. Hierbei gibt es standardmäßig einen **Haupt-** und einen **Nebensatz** (1, 2). Der **Hauptsatz** kann weggelassen werden, wenn mehrere Sätze in Folge denselben bzw. einen ähnlichen Hauptsatz hätten (3).

1: Die Patientin sagte, sie habe die Schmerzen seit 2 Wochen.

2: Der Patient berichtete, dass er seit 3 Jahren an arterieller Hypertonie leide.

3: (Sie sagte, …) Sie sei Nichtraucherin und trinke gelegentlich Alkohol.

Der Konjunktiv passt sich zudem der Zeitform des Gesagten an. Bei Aussagen von Patient:innen im Präsens, wird der Konjunktiv im Präsens gebildet.

4: „Ich **habe** seit gestern Schmerzen.“ → Sie **habe** seit gestern Schmerzen.

5: „Ich **bin** sehr traurig.“ → Sie **sei** sehr traurig.

Bei Aussagen von Patient:innen im Präteritum, Perfekt oder (selten) Plusquamperfekt, wird auch der Konjunktiv im Perfekt gebildet.

6: „Ich **hatte** gestern Schmerzen.“ → Sie **habe** gestern Schmerzen **gehabt**.

7: „Ich **war** sehr traurig.“ → Sie **sei** sehr traurig **gewesen**.

Ist der Konjunktiv I mit dem Indikativ identisch, so wird ersatzweise der Konjunktiv II verwendet. Dies ist häufig der Fall, wenn Subjekte im Plural stehen. Ist wiederum der Konjunktiv II identisch mit dem Indikativ des Präteritums, wird die Umschreibung mit „würde“ genutzt.

8: „Meine Kinder **haben** keine Vorerkrankungen.“ → Seine Kinder **hätten** keine Vorerkrankungen.

9: „Die Schmerzen **haben** gestern plötzlich **begonnen**.“ → Die Schmerzen **hätten** gestern plötzlich **begonnen**.

10: „Die Schmerzen **fühlen** sich stechend an.“ → Die Schmerzen **würden** sich stechend **anfühlen**.

Und zuletzt: Auch bei Aussagen von Patient:innen im Passiv wird der Konjunktiv im Passiv verwendet.

11: „Ich **werde** häufig von meinen Kindern **geweckt**.“ → Sie **werde** häufig von ihren Kindern **geweckt**.

12: „Ich **wurde** bislang nicht **operiert**.“ → Sie **sei** bislang nicht operiert **worden**.

2 - Mit Infinitiv

Zum Glück gibt es im Deutschen auch Formen der indirekten Rede, die etwas leichter sind. Beispielsweise die Formulierung mit Infinitivkonstruktionen. In diesem Fall muss der Hauptsatz immer vorhanden sein.

13: „Ich habe Schmerzen.“ → Sie gab an, Schmerzen **zu haben**.

14: „Ich bin häufig müde.“ → Sie berichtete davon, häufig müde **zu sein**.

Die Formulierung mit Infinitivkonstruktion ist nicht bei allen „einleitenden“ Verben möglich. Am häufigsten werden „Er/sie gab an…“ sowie „Er/sie berichtete davon…“ verwendet. Im Folgenden ein paar Beispiele:

15: Sie gab an, krank zu sein.

16: Sie berichtete davon, krank zu sein.

~~17: Sie sagte, krank zu sein.~~

~~18: Sie fragte, krank zu sein.~~

~~19: Sie nannte, krank zu sein.~~

Die Bildung mit Infinitiv funktioniert nur, wenn Subjekt des Haupt- und Nebensatzes identisch sind (also bspw. bei „Ich“- und „Wir“-Aussagen. In den folgenden Fällen funktioniert es daher nicht:

20: „Meine Kinder haben keine Vorerkrankungen.“ → **X**

21: „Die Schmerzen treten besonders nachts auf.“ → **X**

3 - Mit Substantiv (ohne Nebensatz)

Die vermutlich einfachste Form der indirekten Rede ist es, Nebensätze (und somit weitere Verben) zu vermeiden. Somit steht nur ein Verb im Hauptsatz (meist im Präteritum). Dies geht insbesondere bei Aufzählungen gut.

22: Sie **berichtete** von Fieber, Nachtschweiß und Schüttelfrost.

23: Die Familienanamnese **ergab** eine chronische Zystitis bei der Mutter sowie ein Kolonkarzinom beim Vater.

24: Er **stellte** sich heute mit starken Abdominalschmerzen im rechten unteren Quadranten bei uns **vor**.

25: Im Zuge der vegetativen Anamnese **gab** sie einen ungewollten Gewichtsverlust von 3 Kilo in 2 Monaten sowie Insomnie **an**.

26: Die vegetative Anamnese **war** unauffällig bis auf Fieber und schmerzbedingte Insomnie.

~~27: Die vegetative Anamnese sei unauffällig gewesen.~~

Beachte, dass im vorigen Satz der Konjunktiv I nicht verwendet werden darf, da der Patient keine Aussagen zur *vegetativen Anamnese* getroffen hat. Du hast die Anamnese erhoben und kannst diese Aussage daher im Indikativ treffen. Dieser Satz wäre nur korrekt, wenn du bspw. dem Oberarzt sagst: „Die vegetative Anamnese *war* unauffällig.“ und er diese Information an eine andere Kollegin weitergibt. Dann wiederholt er deine Aussage (über die vegetative Anamnese) in der indirekten Rede.

4 - Mit Präpositionen

Auch mit der Verwendung von **Präpositionen** kannst du dem Konjunktiv „entgehen“.

28: **Gemäß** der Patientin lag das Fieber am Morgen bei 39 Grad.

29: **Laut** dem Patienten haben die Schmerzen vor 3 Stunden eingesetzt.

30: **Nach Aussage des Patienten** leidet seine Mutter an einer chronischen Zystitis.

31: Den Angaben der Patientin **zufolge** ereignete sich der Unfall um 8 Uhr.

5 - „Mit Indikativ“

Wie oben beschrieben, verlangen nicht alle Ärztekammern die durchgängige Verwendung des Konjunktivs in der indirekten Rede. Ersatzweise können Aussagen also auch im Indikativ wiedergegeben werden. Hierbei ist es wichtig, **keinen** einleitenden Satz zu verwenden, da dieser **zwingend** den Konjunktiv fordert.

32: Sie ist Nichtraucherin.

~~33: Sie sagte, sie ist Nichtraucherin.~~

34: Er hatte eine Appendektomie im Alter von 25 Jahren.

~~35: Er sagte, er hatte eine Appendektomie im Alter von 25 Jahren.~~

Sätze, die "nie" im Konjunktiv stehen.

- ~~Die vegetative sei unauffällig gewesen.~~
- ~~Die Schmerzen seien mit 7/10 auf der Schmerzskala bewertet worden.~~ (Die Schmerzen wurden mit 7/10 auf der Schmerzskala bewertet. - Die Schmerzen seien eine 7/10 auf der Schmerzskala.)
- ~~Die Frage nach … sei verneint worden.~~
- ~~Der Patient habe sich vorgestellt.~~
- ~~Der Patient habe gefragt, ob die OP schmerzhaft sei.~~

Konjunktiv-Regeln für die indirekte Rede

Wie ihr wisst, verwendet man für die indirekte Rede häufig den Konjunktiv. Doch nicht immer wird der Konjunktiv I verwendet. Es kann auch sein, dass der Konjunktiv II oder die Umschreibung mit "würde" verwendet werden. Warum? Weil der Konjunktiv I und II manchmal nicht vom Indikativ unterschieden werden können.

Konjunktiv I

Patient: "Ich habe Schmerzen."

(Ind. Präsens: er *hat*)

Konj. I: Der Patient sagte, er ***habe*** Schmerzen.

→ ✓**Konj. I** (*habe*) unterscheidet sich von Indikativ Präsens (*hat*)

Konjunktiv II

Patient: "Die Schmerzen haben gestern plötzlich begonnen."

(Ind. Präsens: Die Schmerzen *haben* begonnen.)

Konj. I: Die Schmerzen ***haben*** gestern plötzlich begonnen.

→ ✗**Konj. I** (*haben*) ist identisch mit Indikativ Präsens (*haben*)

(Ind. Präteritum: sie *hatten*)

Konj. II: Die Schmerzen ***hätten*** gestern plötzlich begonnen.

→ ✓**Konj. II** (*hätten*) unterscheidet sich von Indikativ Präteritum (*hatten*)

Umschreibung mit "würde"

Patient: “Die Schmerzen strahlen in die linke Schulter aus.”

(Ind. Präsens: sie *strahlen*)

Konj. I: Die Schmerzen ***strahlen*** in die linke Schulter aus.

→ ✗**Konj. I** (*strahlen*) ist identisch mit Indikativ Präsens (strahlen)

(Ind. Präteritum: sie *strahlten*)

Konj. II: Die Schmerzen ***strahlten*** in die linke Schulter aus.

→ ✗**Konj. II** (*strahlen*) ist identisch mit Indikativ Präsens (strahlen)✗

→ ✓**Umschreibung mit “würde”**: Die Schmerzen ***würden*** in die linke Schulter ***ausstrahlen***.

Übungen

Weitere **kostenlose Übungen** zu diesem Thema findest du auf unserer **Online-Lernplattform:**

app.medeki.de

Übungen → Konjunktiv in der indirekten Rede

Indikativ (Patientenaussage)	**Konjunktiv (Dokumentation)**
3. Person Singular - Präsens	Der Patient sagte, dass…
Ich bin krank.	… er krank *sei*.
Ich habe Schmerzen.	… er Schmerzen *habe*.
Ich fühle mich krank.	… er sich krank *fühle*.
Ich kann nicht sehen. *Modalverb*	… er nicht sehen *könne*.
Ich werde behandelt. *Passiv*	… er behandelt *werde*.
3. Person Singular - Vergangenheit	Der Patient sagte, dass…
Ich war letzte Woche krank.	… er letzte Woche krank gewesen *sei*.
Ich hatte Schmerzen.	… er Schmerzen gehabt *habe*.

Ich habe mich letzte Woche krank gefühlt.	… er sich letzte Woche krank gefühlt *habe*.
Ich konnte nicht sehen. *Modalverb*	… er nicht *habe* sehen können. **(Ausnahme)**
Ich wurde behandelt. *Passiv*	… er behandelt worden *sei.*
3. Person Plural - Präsens	Der Patient sagte, dass…
Die Schmerzen sind unangenehm.	… die Schmerzen unangenehm ***seien***.
Die Ärzte haben keinen Verdacht.	… die Ärzte keinen Verdacht ***hätten***. (Konj. II)
Die Schmerzen werden nachts schlimmer.	… die Schmerzen nachts schlimmer *würden*. (Konj. II)
Die Schmerzen strahlen in die linke Schulter aus.	… die Schmerzen in die linke Schulter ausstrahlen ***würden***.
Die Schmerzen treten morgens ein.	… die Schmerzen morgens eintreten würden.
Die Medikamente müssen helfen. *Modalverb*	… die Medikamente helfen *müssten*.
Die Schmerzen werden behandelt. *Passiv*	… die Schmerzen behandelt *würden*.
3. Person Plural - Vergangenheit	Der Patient sagte, dass…
Die Schmerzen waren unangenehm.	… die Schmerzen unangenehm gewesen *seien*.
Die Ärzte hatten keinen Verdacht.	… die Ärzte keinen Verdacht gehabt *hätten*.
Die Schmerzen wurden nachts schlimmer.	… die Schmerzen nachts schlimmer geworden *seien*.
Die Schmerzen haben sich jeden Tag verändert.	… die Schmerzen sich jeden Tag verändert *hätten*.
Die Schmerzen sind gestern eingetreten.	… die Schmerzen gestern eingetreten *seien*.
(Die Medikamente mussten helfen. *Modalverb*)	… die Medikamente *hätten* helfen müssen. **(Ausnahme)**

Die Schmerzen wurden behandelt. *Passiv*	… die Schmerzen behandelt worden seien.

Regel-Tabelle

	Singular (3. Person)	*Plural (3. Person)*
Präsens	sei**n** → sei (Konj. I) *Der Patient sei ledig.* habe**n** → habe (Konj. I) *Die Patientin habe zwei Kinder.* **"anderes Verb"** → **Infinitiv minus "n"** (Konj. I) *Der Patient leide seit 3 Monaten an Dysphagie.* *Der Patient werde krank.* **Modalverb** + **Verb** → Modalverb minus "n" + Verb im Infinitiv *Der Patient **könne** nicht **sehen**.* *Der Patient **müsse** sich regelmäßig **übergeben**.* Passiv (**werden** + **Partizip II**) → "werde" + Partizip II *Der Patient **werde** nicht **behandelt**.* *Der Patient **werde** gerade **untersucht**.*	sein → seien (Konj. I) *Die Schmerzen seien drückend.* haben → **hätten** (Konj. II) *Seine Kinder hätten ähnliche Symptome.* *werden → würden* *Die Schmerzen würden schlimmer.* **"anderes Verb" → würden + Infinitiv** *Die Schmerzen würden in die Schulter ausstrahlen.* *(Die Schmerzen würden schlimmer werden.)* **Modalverb** + **Verb** → Modalverb im Konj. II + Verb im Infitniv Die Patienten **könnten** nicht **sehen**. Die Patienten **müssten** sich regelmäßig **übergeben**. Passiv (**werden** + **Partizip II**) → würden + Partizip II *Die Patienten **würden** nicht **behandelt**.* *Die Patienten **würden** gerade **untersucht**.*
Präteritum /	Verb mit "sein" → sei + Partizip II	Verb mit "sein" → seien + Partizip II

Perfekt	*Er sei gestern gestürzt.* *Er **sei** gestern krank **gewesen**.* *Der Patient sei krank geworden.* Verb mit "haben" → habe + Partizip II *Er habe vor zwei Jahren mit dem Rauchen aufgehört.* *Er **habe** letztes Jahr einen Unfall **gehabt**.* **Modalverb** + **Verb** → habe + Infinitiv Verb + Infinitiv Modalverb **Achtung**: Kein Partizip 2 trotz Perfekt!! Und konjugiertes Verb steht vor doppeltem Infinitiv! *Der Patient habe nicht **sehen können**.* *Der Patient habe sich regelmäßig **übergeben müssen**.* Passiv (**werden** + **Verb**) → sei + Partizip II + worden **Achtung**: Immer "sei", niemals "habe", da "werden" mit "sein" im Perfekt steht *Der Patient sei nicht **behandelt worden**.* *Der Patient sei **untersucht worden**.*	*Die Schmerzen seien gestern eingetreten.* *Die Schmerzen seien letzten Monat stärker gewesen.* *Die Schmerzen seien schlimmer geworden.* Verb mit "haben" → hätten + Partizip II *Die Schmerzen hätten gestern angefangen.* *Seine Eltern **hätten** letztes Jahr einen Unfall **gehabt**.* **Modalverb** + **Verb** → hätten + Infinitiv Verb + Infinitiv Modalverb **Achtung**: Kein Partizip 2 trotz Perfekt!! Und konjugiertes Verb steht vor doppeltem Infinitiv! *Die Patienten **hätten** nicht **sehen können**.* *Die Patienten **hätten** sich regelmäßig **übergeben müssen**.* Passiv (**werden** + **Verb**) → seien + Partizip II + worden **Achtung**: Immer "sei", niemals "habe", da "werden" mit "sein" im Perfekt steht *Die Patienten seien nicht **behandelt worden**.* *Die Patienten seien **untersucht worden**.*

Arzt-Patienten-Gespräch

Struktur des Arzt-Patienten-Gesprächs

1. Allgemeine Informationen

Begrüßung sowie Erfassung der grundlegenden persönlichen Daten zur Identifikation des Patienten.

Begrüßung

Die Begrüßung des Patienten ist der allererste Eindruck, den du in der Prüfung hinterlässt. Sie sollte **sprachlich perfekt** sowie höflich und freundlich sein. Dein erster Redeabschnitt sollte daher die folgenden Punkte beinhalten:

Freundliche Begrüßung

- Guten Tag, …

Kurze Vorstellung

- mein Name ist Müller. Ich bin heute der behandelnde Arzt (die behandelnde Ärztin) auf dieser Station und werde das Aufnahmegespräch mit Ihnen führen. *Nur Vorname würde man nur bei Kindern sagen. Nachname oder Vorname + Nachname ist professionell.*

Erklärung des Ablaufs

- Zuerst werde ich dafür Ihre persönlichen Daten erfassen und danach kommen wir direkt zu Ihren Beschwerden.

Erste Frage an den Patienten

- Ist das für Sie in Ordnung?
- Sind Sie damit einverstanden?
- Ist das okay für Sie?

Name

- Wie heißen Sie?
- Könnten Sie mir bitte Ihren vollständigen Namen sagen?
- Könnten Sie Ihren Vor- und Nachnamen bitte langsam buchstabieren?
- Könnten Sie Ihren Nachnamen bitte langsam buchstabieren?
- Spreche ich Ihren Namen so richtig aus?

→ medeKI: Alphabet, Namen

Alter & Geburtsdatum

- Wie alt sind Sie?
- Wann sind Sie geboren?
- Wie alt sind Sie und wann sind Sie geboren?
- Wann ist Ihr Geburtstag?
- An welchem Tag? *(Rückfrage)*
- In welchem Monat? *(Rückfrage)*
- In welchem Jahr? *(Rückfrage)*
- Oh, Sie hatten ja gestern Geburtstag. Ich wünsche Ihnen noch alles Gute nachträglich.
- Oh, das ist ja morgen. Wie schade, dass Sie an Ihrem Geburtstag krank sind.

→ medeKI: Geburtsdatum

Hausarzt / Hausärztin

- Wer ist Ihr Hausarzt?
- Wie heißt Ihr Hausarzt?
- Bei wem sind Sie hausärztlich in Behandlung?
- Bei wem befinden Sie sich in hausärztlicher Behandlung?
- *Bei Arbeitsunfall ggf. Frage nach Durchgangsarzt: https://orthopaede-stuttgart.com/was-ist-ein-durchgangsarzt/*

Ankunft

- Wie sind Sie zu uns gekommen?
- Sind Sie selbstständig/allein zu uns gekommen?
- Wer hat Sie hergebracht?
- Wurden Sie mit dem Rettungswagen gebracht?
- Wurden Sie (im Rettungswagen) bereits versorgt (erste Hilfe)?

Krankenversicherungsstatus

- Sind Sie privat oder gesetzlich versichert?

Größe und Gewicht

siehe Kapitel "Vegetative Anamnese"

Größe und Gewicht können zu Beginn des Gesprächs abgefragt werden oder später bei der vegetativen Anamnese. Das spätere Abfragen hat den Vorteil, dass der Patient schneller über seine Symptome sprechen kann.

Allergien (insb. gegen Medikamente)

siehe Kapitel "Allergien & Unverträglichkeiten"

Tipps & Tricks

- Buchstabiertafel lernen, um gezielt Rückfragen stellen zu können
- Geburtsdaten üben, insbesondere auch für Rückfragen
- Bei Geburtsdatum kurz prüfen, ob es in naher Vergangenheit oder Zukunft liegt und ggf. kurz empathisch reagieren

2. Beschwerden

Erfassung des Hauptanliegens und der aktuellen Beschwerden des Patienten.

Hauptanliegen

- Was führt Sie heute zu uns?
- Welche Beschwerden führen Sie heute zu uns?

- Wie kann ich Ihnen helfen?

Details zu Schmerzen

Details zu Schmerzen sollten bestenfalls nach einem Schema (Plural: Schemata) abgefragt werden, um keine wichtigen Informationen zu vergessen. Die beiden bekanntesten Schemata sind **OPQRST** und **SOCRATES**. Sie beinhalten an sich dieselben Informationen, mit leicht unterschiedlichen Bezeichnungen. Der Übersicht halber ("Im Sinne der Übersicht") werden die Informationen hier entlang des OPQRST-Schemas aufgelistet.

Onset (Beginn)

- Seit wann haben Sie diese Schmerzen?
- Wann haben die Schmerzen begonnen?
- Wann sind die Schmerzen eingetreten?
- Sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten?
- Gab es einen konkreten Auslöser für die Beschwerden?
- Haben Sie ähnliche Schmerzen (früher) schon einmal gehabt?
- Waren Sie wegen dieser Beschwerden schon einmal beim Arzt?
- *ggf. Fragen zu Unfallhergang / Event (siehe "Trauma-Details")*

Provocation/Palliation (Verstärkung, Linderung)

- Gibt es etwas, das die Schmerzen verstärkt oder lindert?
- Haben Sie Medikamente gegen diese Schmerzen eingenommen? Haben diese gewirkt?

Quality (Schmerzcharakter)

- Könnten Sie genauer beschreiben, wie sich die Schmerzen anfühlen?
- Sind sie eher drückend, stechend oder brennend?
- *dumpf, kolikartig, krampfartig, ziehend, hämmernd, pochend, klopfend*

Region & Radiation (Ort & Ausstrahlung)

- Wo genau haben Sie die Schmerzen?
- Könnten Sie mir zeigen, wo genau Sie die Schmerzen haben?
- Sind die Schmerzen immer an derselben Stelle?
- Waren die Schmerzen von Anfang an dort oder sind sie mit der Zeit gewandert?
- Gibt es eine Ausstrahlung der Schmerzen **in** andere Körperteile?
- Strahlen die Schmerzen (irgendwo**hin**) aus?
- Wo**hin** strahlen die Schmerzen aus?
- Haben Sie das Gefühl, dass die Schmerzen sich in einen anderen Bereich ausbreiten?

Severity (Stärke / Intensität)

- Auf einer Skala von eins bis zehn: Wie stark sind Ihre Schmerzen?
- Eins steht für sehr leichte Schmerzen und 10 für die größtmöglichen Schmerzen.

Time (Zeitlicher Verlauf)

- Sind die Schmerzen mit der Zeit besser oder schlechter geworden? (stärker oder schwächer)
- Sind die Schmerzen dauerhaft vorhanden?
- Sind die Schmerzen wellenförmig? (episodisch)
- Wie lange dauert eine Schmerzepisode?
- Wie oft/häufig haben Sie die Schmerzepisoden?
- Haben Sie schmerzfreie Phasen?
- Sind die Schmerzen zu einer bestimmten Tages- oder Nachtzeit stärker?

Begleitsymptome

Zusätzlich zu den Schmerzen können einige Begleitsymptome auftreten. Je nach Leitsymptom sollten hier bestimmte Kategorien abgefragt werden. Sollte ein Patient ein Begleitsymptom bejahen ("ja" sagen), sollten weiterführende Fragen gestellt werden, um die Details zu diesem Begleitsymptom zu klären.

Sollten Begleitsymptome vorhanden sein, sollte auch nachgefragt werden, ob der Patient bereits Medikamente (oder Hausmittel) aufgrund dieser Symptome verwendet hat und - wenn ja - welche und wie häufig.

Fieber & Infektionssymptome

- Haben Sie Fieber?
- Haben Sie Fieber gemessen?
- Wie hoch war das Fieber?
- Wann haben Sie es zuletzt gemessen?
- Wie/Wo haben Sie es gemessen? Im Mund, in der Achsel, oder anal?
- Haben Sie Nachtschweiß oder Schüttelfrost bemerkt?
- Haben Sie Gliederschmerzen?

Herz-Kleislauf

- Haben Sie Herzklopfen (Palpitationen) oder Herzrasen (Tachykardie) bemerkt?
- Haben Sie einen unregelmäßigen Puls oder Herzstolpern (Extrasystole) gespürt?
- Messen Sie regelmäßig Ihren Blutdruck?
- Ist Ihnen in letzter Zeit schwarz vor Augen geworden?
- Sind Sie ohnmächtig (Synkope) geworden? → das Bewusstsein verlieren (zu Bewusstsein kommen)

Schwindel

- Ist Ihnen häufig schwindelig?
- Wie äußert sich der Schwindel?
- Haben Sie das Gefühl, Ihr Gleichgewicht zu verlieren?
- Sind Sie aufgrund des Schwindels umgekippt?

Gehör

- Haben Sie Probleme mit dem Hören?
- Können Sie noch etwas hören? (Gehörlosigkeit, Taubheit)

- Hören Sie manchmal ein Klingeln in Ihrem Ohr?

Husten

- Haben Sie Husten?
- Seit wann haben Sie den Husten?
- Ist der Husten mit Auswurf (Schleim)?
- Ist der Husten trocken oder mit Auswurf?
- Ist der Husten blutig? Haben Sie auch Blut gehustet?
- Könnten Sie mir die Konsistenz und Farbe des Schleims beschreiben?
- Haben Sie Hustenanfälle/Hustenattacken? Wie lange dauern diese?
- Haben Sie Atemnot wegen des Hustens?

Atmung

- Haben Sie Probleme beim Atmen?
- Haben Sie manchmal das Gefühl, schlecht Luft zu bekommen?
- Tritt die Atemnot nur bei Belastung auf?
- Tritt die Atemnot nur bei Belastung bzw. Bewegung auf?
- Sind Ihre Atemwege frei?
- Haben Sie Schnupfen bzw. eine laufende/verstopfte Nase?

Übelkeit / Erbrechen

- Ist Ihnen auch übel?
- Haben Sie nur gewürgt oder auch erbrochen? (Würgereiz, Brechreiz)
- Haben Sie sich erbrochen? Haben Sie erbrochen?
- Haben Sie sich übergeben? ~~Haben Sie übergeben?~~
- Wie häufig haben Sie erbrochen?
- Könnten Sie mir die Konsistenz und Farbe des Erbrochenen beschreiben?
  → Konsistenz: flüssig, breiig, mit Stücken
  → Farbe: gelblich, bräunlich, durchsichtig, klar, rötlich!!
- Haben Sie Blut in Ihrem Erbrochenen bemerkt?
- Gibt es bestimmte Auslöser für die Übelkeit (bzw. das Erbrechen)?
- → umgangssprachlich: kotzen (bei Erwachsenen), spucken (bei Babys)

Schluckbeschwerden

- Haben Sie Schwierigkeiten beim Schlucken?
- Treten die Beschwerden nur bei fester oder auch bei flüssiger Nahrung auf?
- Haben Sie Schmerzen beim Schlucken?
- Haben Sie Sodbrennen?
- Haben Sie das Gefühl, einen Kloß im Hals zu haben?

Neurologische Beschwerden

- Haben Sie Sprachstörungen bemerkt?
- Haben Sie Probleme mit dem Sprechen?

- Haben Sie Probleme mit dem Sehen? Beispielsweise verschwommenes Sehen, Lichtblitze oder sehen Sie alles doppelt?
- Fühlen Sie ein Kribbeln oder Taubheitsgefühl in Ihren Beinen (Armen, …)? → Ameisen unter der Haut, “mein Bein ist eingeschlafen”
- Können Sie Ihre Arme und Beine ohne Probleme bewegen?
- Haben Sie Schwäche oder Lähmung(serscheinungen) an Armen oder Beinen?
- Fühlen sich Ihre Arme oder Beine manchmal steif und unbeweglich an?
- Haben Sie häufig Krämpfe in den Beinen / Armen / Händen?
- Haben Sie Konzentrations- oder Gedächtnisprobleme?
- Haben Sie Kopfschmerzen?

Hautveränderung

- Haben Sie Veränderungen Ihrer Haut wahrgenommen?
- Hat sich die Farbe Ihrer Haut verändert?
- Haben Sie eine Verfärbung der Haut (einen blauen Fleck: Hämatom) bemerkt?
- Ist Ihre Haut gelblich (verfärbt)? (Ikterus)
- Sind Ihre Augen gelblich?
- Ist Ihre Haut besonders blass? (Pallor)
- Fühlen Sie besondere Wärme (Calor) oder Kälte in dem betroffenen Bereich?
- Ist Ihnen eine Schwellung im betroffenen Bereich aufgefallen? (Ödem)
- Haben Sie Juckreiz? Juckt Ihre Haut? (Pruritus)
- Haben Sie Haarausfall bemerkt? (Alopezie)
- Sind Ihre Nägel brüchig? (Onychoschisis, Onychorrhexis)
- Haben Sie Knoten oder Schwellungen am Hals, in der Achsel oder der Leiste bemerkt?

Wundschmerz

- Wurde Ihre Wunde bereits desinfiziert / gesäubert?
- Haben Sie Rötung, Schwellung oder Sekret an der Wunde bemerkt?
- Tritt Flüssigkeit oder Eiter (Pus) aus der Wunde aus?
- Riecht die Wunde unangenehm?
  → Abschürfung, Schürfwunde, Schnittwunde, Stichwunde, Bisswunde, Platzwunde, Brandwunde, Frostbiss, Geschwür, OP-Wunde, “Wunde aufgerissen, geöffnet”
  → Wundheilungsstörung

Muskel- / Gelenksymptome

- Haben Sie Gelenkschmerzen oder -schwellungen?
- Haben Sie Muskelschmerzen oder -schwäche?
- Können Sie Ihre Gelenke gut bewegen?
- Fühlen sich Ihre Gelenke morgens steif an?

Psychologische Symptome

- Fühlen Sie sich häufig müde oder abgeschlagen?
- Haben Sie manchmal Angstgefühle oder empfinden Sie viel Stress?
- Fühlen Sie sich häufig traurig, niedergeschlagen oder antriebslos?
- Haben Sie das Interesse an Dingen verloren, die Ihnen früher Freude bereitet haben?
- Haben Sie manchmal Suizidgedanken (Selbstmord)?
- Haben Sie manchmal das Gefühl, andere Personen oder sich selbst verletzen zu wollen?

Frage zu Medikamenten

- Haben Sie bereits Medikamente gegen … eingenommen?
- Hat das geholfen?

Schmerz-Verhalten

- *Bei Schmerzen, Atemnot, etc. ab ~6/10 angemessen*
- Es tut mir leid, dass Sie so starke Schmerzen / Atemnot haben.
- Können Sie die Schmerzen gerade (bis zum Ende des Gesprächs) ertragen?
- Haben Sie heute bereits Medikamente (gegen die Schmerzen) eingenommen?
- *Falls ja:* Welche Medikamente? Wie viel? Welche Dosis? Hat das geholfen?
- Sind bei Ihnen irgendwelche Allergien gegen Medikamente bekannt?
- Dann würde ich Ihnen jetzt gerne einen Zugang legen, um Ihnen das Medikament verabreichen zu können. Ist das in Ordnung für Sie?

Notfall-Verhalten

- Aufgrund Ihrer Beschwerden würde ich gerne **sofort** ein paar Untersuchungen **veranlassen**, damit wir uns schnell ein besseres Bild machen können.
- Insbesondere würde ich gerne sofort ein Ultraschall / Röntgen (...) durchführen.
- Ist das für Sie in Ordnung?
- Super. Während der Untersuchungen (In der Zwischenzeit / Während wir die Untersuchungen vorbereiten) werde ich Ihnen weitere Fragen stellen…
- *Am Ende:* Wie vorhin angesprochen sollten wir jetzt schnellstmöglich die Untersuchungen durchführen. Es ist bereits alles vorbereitet. Wir können sofort starten.
- *Alternative*: Wir haben ja bereits die Untersuchungen durchgeführt. Wir warten noch auf die Ergebnisse. (Ich werde gleich die Ergebnisse überprüfen.)
- ~~*An die Kommission: Liebe Kommission, ich würde das Gespräch jetzt unterbrechen und diese und diese Untersuchung durchführen.*~~
- ~~Es könnte sich bei Ihnen um einen Notfall handeln…~~
- ~~Bitte nehmen Sie im Wartezimmer Platz.~~

Trauma-Details / Orthopädie

Unfallhergang / Unfallverlauf / Hergang

- Bitte erzählen Sie mir, was genau passiert ist.
- Wann genau ist das passiert?
- Waren Sie allein?
- Gab es eine Fremdeinwirkung?
- Sind Sie alleine hier?
- Können Sie sich an den Unfallhergang erinnern?
- Gibt es andere Personen, die uns mehr Informationen zum Unfallhergang geben könnten?
- Wie sind Sie zu uns gekommen? Wurden Sie von jemandem gebracht? Hat der Krankenwagen Sie abgeholt?
- Wurde die Wunde bereits versorgt? Das heißt zum Beispiel gereinigt, …?

  → *siehe Wundschmerz*
- Waren Sie auf dem Weg zur Arbeit? *(aus Versicherungsgründen wichtig)*
- Welche Körperteile haben Sie verletzt?
- Können Sie Ihre Körperteile (Arme, Beine, Hände, Kopf) ohne Probleme bewegen? → *siehe Bewegungen*
- Können Sie gut atmen?
- Auf welche Seite sind Sie gestürzt?
- Wie schnell waren Sie unterwegs?
- Waren Sie in dem Auto, das den Unfall hatte oder waren Sie außerhalb?
- Gibt es eine aktive Blutung?
- Gibt es eine offene Wunde?
- Kennen Sie Ihre Blutgruppe?
- Haben Sie ein Knacken oder einen Knall gehört?
- Haben Sie Ihren Kopf verletzt?
- Haben Sie (sich) Ihren Kopf angeschlagen / gestoßen?
- Woran haben Sie Ihren Kopf gestoßen? **War es ein spitzer oder dumpfer Aufprall?**

  → *siehe Neurologische Beschwerden*
- Haben Sie einen Helm getragen? Ist der Helm beschädigt?
- Haben Sie Ihr Bewusstsein verloren? Wenn ja: Wie lange?
- Standen Sie während des Unfalls unter dem Einfluss von Drogen / Alkohol?
- Waren Sie zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert?

Orientierung

- Könnten Sie mir Ihren Namen sagen?
- Wissen Sie, welchen Tag wir heute haben?
- Wissen Sie, wo Sie gerade sind?

  → Der Patient war zu Person, Zeit und Ort orientiert.

Bewegungen

- Allgemein
  - Haben Sie Schmerzen, wenn Sie Ihren Arm (...) bewegen?
- Hand
  - Können Sie die Hand zu einer Faust machen?
  - Können Sie eine Faust machen?
  - Können Sie die Hand schließen?
  - Können Sie die Hand öffnen?
  - Können Sie die Hand nach oben und unten drehen? (Handfläche, Handrücken)
- Finger
  - Können Sie Ihre Finger spreizen?
  - Welcher Finger tut Ihnen weh?
  - der Daumen → der Zeigefinger → der Mittelfinger → der Ringfinger → der kleine Finger
- Arm
  - Können Sie den Arm (aus)strecken?
  - Können Sie den Arm nach vorne (zur Seite) ausstrecken?
  - Können Sie den Arm beugen?
  - Können Sie den Arm (an)heben?
  - Können Sie den Arm anlegen?
  - Können Sie den Arm kreisen?
- Hals / Nacken / Kopf
  - **Achtung: Bei Verdacht auf Verletzungen der HWS bitte nicht danach fragen!**
  - Können Sie Ihren Kopf nach vorne beugen? (sich verneigen)
  - Können Sie Ihren Kopf nach hinten strecken?
  - Können Sie Ihren Kopf in den Nacken legen?
  - Können Sie Ihren Kopf nach links / nach rechts drehen?
  - Können Sie Ihren Kopf auf die rechte / linke Seite legen?
- Oberkörper
  - Können Sie Ihren Oberkörper nach vorne beugen?
  - Können Sie Ihren Oberkörper nach hinten strecken?
  - Können Sie Ihren Oberkörper zur Seite drehen?
  - Können Sie Ihren Oberkörper auf die rechte / linke Seite legen? (nach rechts/links kippen)
  - Haben Sie Schmerzen beim tief Luft holen?
  - Haben Sie Schmerzen beim Ein- oder Ausatmen?
- Beine
  - Können Sie Ihre Beine spreizen?

    - Können Sie Ihre Beine strecken?
    - Können Sie Ihre Beine anwinkeln / beugen?
    - Können Sie Ihre Beine anheben?
    - Können Sie problemlos in die Hocke gehen? (*eine Kniebeuge machen*)
    - Können Sie auf einem Bein stehen?
- Fuß
    - Können Sie Ihr Sprunggelenk bewegen?
    - Können Sie auf den Zehenspitzen stehen?
    - Können Sie auf den Fersen stehen?
    - Können Sie auf Ihren Fußkanten stehen?
    - Können Sie Ihre Zehen spreizen / bewegen?
    - Haben Sie Schmerzen beim Auftreten?
      → Die Schmerzen treten beim Auftreten auf.

Fortbewegungsmittel

- Auto
- Fahrrad
- Motorrad
- Roller
    - Was für ein Roller war das?
    - City-Roller / Tretroller
    - E-Roller / E-Scooter
    - Motorroller, Mofa
- Skateboard
- Rollschuhe
- Inliner / Inline-Skates
- Schlittschuhe
- Bus
- Straßenbahn, Tram
- Zug, S-Bahn, U-Bahn
- LKW, Lastwagen
- Flugzeug

Untergrund, etc.

- Auf welchem Untergrund sind Sie gestürzt?
    - **Draußen**
    - das Gras, die Wiese
    - das (nasse) Laub
    - der Sand

    - der Kies
    - der Schotter
    - das Kopfsteinpflaster (besteht aus Pflasterstein)
    - der Asphalt → das Schlagloch
    - der Beton, Zement
    - der Schnee
    - die Pfütze
    - der Schlamm, der Matsch
    - das Eis, vereist, glatt
    - **Drinnen**
    - die Fliesen
    - der Stein, der Steinboden
    - das Marmor, der Marmorboden
    - die Treppe, das Geländer, die Wendeltreppe, die Treppenstufe
    - das Holz, der Holzboden
    - der Teppich, der Teppichboden
- Wogegen sind Sie gestoßen?
    - der Hydrant
    - der Gartenzaun
    - die Bordsteinkante
    - der Gullydeckel

3. Vegetative Anamnese

Überprüfung der allgemeinen Körperfunktionen, um den Gesundheitszustand besser einzuschätzen.

Appetit

- Hat sich Ihr Appetit in letzter Zeit verändert?
- Haben Sie mehr oder weniger Durst als sonst?
- Trinken / Essen Sie in letzter Zeit mehr / weniger als gewöhnlich?

Schlaf

- Haben Sie Probleme beim Ein- oder Durchschlafen?

Stuhlgang & Wasserlassen

- Haben Sie Probleme beim Stuhlgang oder mit dem Wasserlassen?
- Wie häufig müssen Sie auf die Toilette?
- Müssen Sie auch nachts mehrmals auf die Toilette (Nykturie)?
- Haben Sie Schmerzen oder ein Brennen beim Wasserlassen (beim Stuhlgang)?

- Haben Sie manchmal ungewollte Urinausscheidungen (Inkontinenz)?
- Tritt bei Ihnen manchmal ungewollt Urin aus?
- Ist Ihr Urinstrahl manchmal unterbrochen?
- Haben Sie starken Harndrang (urgency)?
- Fällt es Ihnen schwer, Wasser zu lassen (Dysurie)?
- Haben Sie in den letzten Wochen Durchfall oder Verstopfung gehabt?
- Wie häufig haben (hatten) Sie Durchfall?
- Könnten Sie mir die Konsistenz und Farbe Ihres Stuhls beschreiben?
- Haben Sie Blähungen (Meteorismus) oder ein Völlegefühl?
- Haben Sie eine Verfärbung des Urins (des Stuhls) bemerkt?
- Ist Ihnen Blut im Urin (im Stuhl) aufgefallen?
- Hat sich der Geruch Ihres Urins (Ihres Stuhls) auffällig verändert?

Gewichtsveränderung

- Hat sich Ihr Gewicht in letzter Zeit (in der letzten Zeit) verändert?
- Wissen Sie, wie viel Kilo und über welchen Zeitraum Sie abgenommen (zugenommen) haben?
- Wie viel wiegen Sie aktuell?
- Wann haben Sie sich zuletzt gewogen?
- Und wie groß sind Sie?

Sonstige Körpergefühle

- Schwitzen Sie in letzter Zeit ungewöhnlich stark?
- Frieren Sie häufig?
- Haben Sie Hitzewallungen oder ein Kältegefühl bemerkt?

Gynäkologische Anamnese

- Besuchen Sie regelmäßig Ihren Frauenarzt?
- Wann waren Sie zuletzt bei Ihrem Frauenarzt?
- Wann hatten Sie Ihre erste Periode?
- Wann hatten Sie Ihre letzte Periode?
- Bekommen Sie (noch) regelmäßig Ihre Periode?
- Sind Sie bereits in den Wechseljahren (Klimakterium)?
- Wie verhüten Sie?
- Verhüten Sie hormonell?
- Haben Sie Kinder?
- War es eine natürliche Geburt?
- Gab es Komplikationen (bei oder nach der Geburt)?
- Stillen Sie noch?

- Besteht die Möglichkeit, dass Sie gerade schwanger sind?

Sexualanamnese

- Haben Sie Schmerzen beim Geschlechtsverkehr (Dyspareunie)?
- Haben Sie eine Veränderung Ihres sexuellen Verlangens bemerkt? (Libido)
- Haben Sie weniger Lust auf Geschlechtsverkehr als sonst?
- Haben Sie Erektionsstörungen bemerkt? (bei männlichen Patienten)
- Haben Sie häufig ungeschützten Geschlechtsverkehr?
- Haben Sie verschiedene Sexualpartner?
- Haben Sie regelmäßig ungeschützten Geschlechtsverkehr mit Männern?

4. Vorerkrankungen & Vor-OPs

Erfassung bereits bekannter oder chronischer Erkrankungen sowie bereits durchgeführter Operationen.

Vorerkrankungen

- Sind bei Ihnen irgendwelche Vorerkrankungen / chronischen Erkrankungen bekannt?
- Beispielsweise hoher Blutdruck, Diabetes, oder eine Darmerkrankung? *(auf Rückfrage des Patienten: "Was meinen Sie mit chronischen Erkrankungen?") Bestenfalls Beispiele nennen, die für "Verdachtsdiagnose" relevant sind.*
- Seit wann ist das bekannt?
- Wann wurde das diagnostiziert?
- Nehmen Sie Medikamente aufgrund dieser Erkrankung ein? *(siehe Medikamente)*
- *Bei hohem Blutdruck:* Messen Sie Ihren Blutdruck regelmäßig? Wann haben Sie Ihren Blutdruck zuletzt gemessen? Nehmen Sie Ihre Medikamente regelmäßig ein oder vergessen Sie es manchmal?
- *Bei Diabetes:* Messen Sie Ihren Blutzucker regelmäßig? Wann haben Sie Ihren Blutzucker zuletzt gemessen? Nehmen Sie Ihre Medikamente regelmäßig ein oder vergessen Sie es manchmal?

Vor-OPs

- Sind Sie schon einmal operiert worden?
- Welche Operationen hatten Sie?
- Wann wurde die OP durchgeführt?
- Wann war das?
- Warum hatten Sie diese Operation?
- Weshalb wurde diese Operation durchgeführt?
- Gab es während oder nach der OP Komplikationen?
- Haben Sie aktuell noch eine Platte (Schraube, Schiene) in Ihrem Körper?
- *Häufiger Fehler: ~~Seit wann war das?~~*
- *Tipp: Manchmal kann eine OP auch auf eine Vorerkrankung hinweisen…*

5. Medikamente

Überblick über dauerhaft oder bei Bedarf eingenommene Medikamente.

- Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein?
- Wissen Sie, wie genau das Medikament heißt?
- Weshalb nehmen Sie dieses Medikament ein?
- Kennen Sie die Dosis?
- Wie häufig nehmen Sie das Medikament ein?
- Nehmen Sie irgendwelche Medikamente bei Bedarf ein? Beispielsweise gegen Schmerzen oder vor dem Einschlafen?
- Haben Sie eine Medikamentenliste dabei?
- Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie unter (an) hohem Blutdruck leiden: Nehmen Sie Medikamente dagegen ein?
- *Wenn der Patient unsicher ist, sollte der Hausarzt kontaktiert werden: Ggf. noch nach Namen fragen (wenn nicht zuvor erfragt) und dann: "Kein Problem, ich werde das bei Ihrem Hausarzt nachfragen."*
- *Tabletten, Lutschtabletten, Zäpfchen, Saft, Tropfen, Kapseln, Salbe, Creme, Spritze, Inhaler, Insulinpumpe, Pulver*
- *Er leide seit 5 Jahren an Diabetes, welchen er anfangs mit Metformin behandelt habe. Seit 2 Jahren nehme er Insulin.*
    - *Früher Metformin*
    - *Seit 2 Jahren Insulin 1-0-1*

6. Allergien & Unverträglichkeiten

Abklärung möglicher allergischer Reaktionen oder Unverträglichkeiten.

- Sind (bei) Ihnen irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt?
- Sind Sie gegen irgendetwas allergisch?
- *Reagieren* Sie allergisch *auf* bestimmte Medikamente?
- Gibt es Lebensmittel, die Sie nicht vertragen?
- Haben Sie eine Lebensmittelunverträglichkeit?
- Wie **äußert** sich diese Allergie (diese Unverträglichkeit)?
- Nehmen Sie manchmal Medikamente gegen diese Allergie (Unverträglichkeit) ein?
- → *allergisch **auf** etwas reagieren bzw. allergisch **gegen** etwas sein*

7. Noxen

Erfassung gesundheitsschädigender Substanzen, die regelmäßig konsumiert werden.

Nikotin

- Rauchen Sie oder haben Sie früher einmal geraucht?
- Wie viele Zigaretten am Tag und seit wann?
- *Shisha, E-Zigarette, Vape*

Alkohol

- Trinken Sie Alkohol?
- Was trinken Sie? Bier, Wein, …?
- Wie häufig und wie viel trinken Sie?
- Was bedeutet "gelegentlich"?
- Alkohol kann einen großen Einfluss auf Ihre Gesundheit haben…
- Alkohol kann auch für Ihre aktuellen Symptome mitverantwortlich sein…
- Aufgrund Ihrer aktuellen gesundheitlichen Probleme würde ich Ihnen empfehlen, in nächster Zeit auf Alkohol zu verzichten.

Drogen

- Haben Sie schon einmal (andere) Drogen konsumiert?
- Konsumieren Sie manchmal Drogen?
- *Erklärung: "Die nächste Frage ist eine Routinefrage, bitte nehmen Sie sie nicht persönlich. Aber ich muss wissen, ob Sie schon einmal Drogen konsumiert haben?"*
- *Beispiel: Patient raucht nicht, trinkt nicht, und sagt "Ich lebe gesund." → "Ich nehme an, dass Sie also auch keine Drogen konsumieren?"*
- *→ Diese Informationen unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht.*
- *→ Selbsthilfekurs / Anonyme Alkoholiker*
- *Vielen Dank, dass Sie mir das anvertraut haben. Ich weiß, dass es unangenehm sein kann, darüber zu sprechen. Aber diese Informationen bleiben unter uns.*

8. Familienanamnese

Ermittlung genetischer oder familiär gehäufter Erkrankungen.

- Sind in Ihrer Familie irgendwelche Krankheiten bekannt?
- Relevante Vorerkrankungen umfassen beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs oder Diabetes.
- Sind Ihre Eltern (Geschwister, Kinder, …) gesund?
- Seit wann leidet Ihr Vater (Ihre Mutter, Ihre Schwester, ...) daran?
- Wer kümmert sich im Alltag um Ihre Schwester (...)?
- Leben Ihre Eltern noch?

- Wann ist Ihr Vater (…) verstorben?
- Woran ist Ihre Mutter (…) verstorben?
- In welchem Alter ist Ihr Vater (...) verstorben?
- Was war die Todesursache?

9. Sozialanamnese

Erfassung der sozialen und beruflichen Lebensumstände, die Einfluss auf die Gesundheit haben können.

Beruf

- Was sind Sie von Beruf?
- Was genau machen Sie als …?
- Wie hoch ist die Stressbelastung?
- Haben Sie viel Stress bei der Arbeit?
- Was sind Ihre Arbeitszeiten?
- Arbeiten Sie in Schichtarbeit?
- Arbeiten Sie noch?
- Arbeiten Sie aktuell? *(Mutterschutz, Elternzeit, Sabbaticals, Urlaub, …)*
- Ich nehme an, Sie sind bereits im Ruhestand. Was waren Sie zuvor von Beruf? *(Rentenalter: ~67 Jahre)*
- Gehen Sie noch zur Schule? Befinden Sie sich noch in Ausbildung?

Familienstand

- Wie ist Ihr Familienstand?
- Sind Sie verheiratet?
- *ledig, verlobt, verheiratet, geschieden, verwitwet*

Kinder

- Haben Sie Kinder? *(falls nicht bereits zuvor gefragt oder in Familienanamnese aufgekommen)*

Lebenssituation

- Leben Sie alleine?
- Mit wem leben Sie zusammen?
- Wo leben Sie?
- In welchem Stockwerk leben Sie? Gibt es einen Aufzug?
- Leben Sie an einer Hauptverkehrsstraße?

Reiseanamnese

- Sind Sie in letzter Zeit im Ausland gewesen?

- Waren Sie in der letzten Zeit im Ausland, beispielsweise in den Tropen?
- Waren Sie in letzter Zeit verreist?
- Wo waren Sie und wie lange?

Impfungen

- Sind Sie geimpft?
- Haben Sie alle empfohlenen Impfungen?
- Wie ist Ihr Impfstatus?
- Haben Sie Ihren Impfpass dabei?
- Wann wurden Sie das letzte Mal gegen Tetanus geimpft?
- Wurden Sie bereits gegen COVID-19 geimpft?
- *Hier findest du die für Deutschland gültigen Impfempfehlungen*

10. Nächste Schritte und ggf. Zusammenfassung

Wenn die Zeit reicht, kannst du eine **kurze (!!)** Zusammenfassung der Hauptbeschwerden sowie potenziell wichtiger Risikofaktoren machen. Auf Basis der Anamnese-Ergebnisse kannst du dann einen ersten Verdacht äußern und das weitere Vorgehen erklären.

Nachfrage

- Möchten Sie noch etwas hinzufügen?

Zusammenfassung

- Herr/Frau …, Sie kamen zu uns wegen …
- Habe ich das richtig verstanden?
- Möchten Sie noch etwas hinzufügen?

Nächste Schritte

- Auf Basis Ihrer Angaben möchte ich gerne weitere Untersuchungen durchführen, um ein genaueres Bild von Ihren Beschwerden zu bekommen.
- Zunächst werde ich Sie körperlich untersuchen.
- Insbesondere werde ich Ihre Lunge abhören (Ihren Bauch abtasten, mir die betroffene Stelle ansehen, …)
- Darüber hinaus werden wir Ihnen Blut abnehmen und im Labor untersuchen lassen.
- Außerdem sollten wir ein Ultraschall (CT, MRT, …) durchführen.
- Im Anschluss werde ich mit dem Oberarzt Rücksprache halten und Sie dann so schnell wie möglich über das weitere Vorgehen informieren. Ist das für Sie in Ordnung?

Verabschiedung

- Herr/Frau …., vielen Dank für das Gespräch.
- Sie können jetzt im Wartezimmer Platz nehmen.
- Bitte nehmen Sie im Wartezimmer Platz.

- Ich werde Sie so schnell wie möglich über die Ergebnisse informieren. (zur Untersuchung aufrufen…)
- Ich werde Sie so schnell wie möglich über das weitere Vorgehen informieren..
- *medeKI-Tipp: Gespräch "schließen" mit Referenz auf Anfang*
  Wir geben unser Bestes, damit Sie in zwei Wochen gesund Ihre Hochzeit feiern können.
  Ich hoffe, dass Sie schnell wieder bei Ihren Kindern zuhause sein können.
  Ich hoffe, dass Sie bald wieder schmerzfrei mit Ihrem Hund Gassi gehen können….

Dokumentation

Wichtig: Sehr lange Sätze, insbesondere direkt zum Einstieg können verwirrend sein. Häufig ist es sprachlich einfacher und schöner, bestimmte Informationen in mehrere Sätze aufzuteilen.

Persönliche Info & Hauptbeschwerden

- Frau Müller ist eine 53-jährige Patientin, die sich heute **wegen** (Genitiv) seit 3 Wochen bestehender, plötzlich eingetretener, progredienter Beschwerden bei uns vorstellte.
- Herr Müller ist ein 53-jähriger Patient, der sich heute **mit** (Dativ) seit 3 Wochen bestehenden, plötzlich aufgetretenen, progredienten Beschwerden bei uns vorstellte.
- Sie stellte sich **aufgrund** (Genitiv) seit 2 Wochen bestehender Schmerzen vor.
- Sie stellte sich **aufgrund von** (Dativ) seit 2 Wochen bestehenden Schmerzen vor.
- Die Schmerzen seien **infolge** (Genitiv) eines Unfalls / beim Heben einer schweren Last / ohne ersichtlichen Auslöser aufgetreten.
- Frau Müller ist eine 23-jährige Patientin, die sich **infolge** eines Fahrradunfalls bei uns vorstellte. Sie habe ein Schlagloch übersehen und sei nach links auf einen Hydranten gefallen. Sie berichtete von einer Platzwunde an der linken Schläfe sowie starken, belastungsabhängigen Schmerzen im linken Sprunggelenk.
- Herr Schneider ist ein 33-jähriger Patient, der heute infolge eines Autounfalls vom Rettungsdienst zu uns gebracht wurde.
- Die Patientin gab eine Ausstrahlung der Schmerzen in den linken Arm / das rechte Bein / den Nackenbereich an. (Die Patientin gab an, dass die Schmerzen in den linken Arm ausstrahlen würden.)
- Die Schmerzen seien eine *6* auf der Schmerzskala.
- Ruhe / Kühlung / Die Einnahme von Ibuprofen würde/n die Schmerzen lindern.
- Der Patient war zu Person, Zeit und Ort orientiert.
- Laut Angabe des *Patienten* ist *er* seit 2 Monaten krank. (Es klingt komisch, "laut" zu verwenden, für Aussagen, die die eigene Person betreffen.)
- Frau Angelika Müller ist eine 3-jährige Patientin, die von ihrer Mutter zu uns gebracht wurde.

Zeitangaben

- Die Schmerzen seien bei Bewegung / am Morgen / morgens / am Mittag / mittags / in der Nacht / nachts / nach dem Essen (postprandial) stärker.
- Die Schmerzen seien letzte Nacht erstmalig und sehr plötzlich aufgetreten.
- Die Schmerzen seien **vor** 3 Stunden aufgetreten / eingetreten. *(Vergangenheit)*
- Er habe **seit** 3 Stunden Schmerzen. *(Gegenwart)*
- (Der Patient sagte,) der Unfall habe sich vor zwei Tagen ereignet. (zwei Tage vor dem jetzigen Zeitpunkt)
- Der Patient sagte, **dass** der Unfall sich vor zwei Tagen ereignet habe.

- Der Unfall habe sich zwei Tage zuvor (vor dem Anamnesegespräch) ereignet. (Zwei Tage vor dem Anamnesegespräch)
- Er habe zwei Stunden vorher / zuvor einen Unfall gehabt.
- Die Schmerzen seien zwei Tage **vor der OP** aufgetreten. Die Schmerzen seien zwei Tage **zuvor** aufgetreten.

Begleitbeschwerden

- Die Patientin berichtete von Vertigo und Nausea seit einer Woche sowie zweimaliger Emesis gestern.
- Der Patient klagte zudem über rezidivierende Schwindelattacken und Gleichgewichtsstörungen seit drei Tagen.
- Die Patientin habe zudem seit 3 Tagen Nykturie, Dysurie sowie Meläna.
- Die Patientin habe zudem seit 3 Tagen Nykturie, und seit gestern Dysurie sowie Meläna.
- Als Begleitsymptome wurden … angegeben.
- Der Patient gab an, seit 2 Tagen Fieber zu haben.

Vegetative Anamnese

- Der Patient habe *5 Kilo in 3 Monaten* zu-/abgenommen.
- Die Patientin berichtete von einer ungewollten Gewichtszunahme von 5 Kilo in 3 Monaten.
- Die vegetative Anamnese **war** unauffällig bis auf *schmerzbedingte Insomnie und Inappetenz*.
- Die vegetative Anamnese ergab Insomnie, Inappetenz, ungewollte Gewichtsveränderung, Konzentrationsstörungen und Amnesie. (Kein unbestimmter Artikel bei abstrakten Substantiven, nicht zählbar)
- Die Frage nach Schüttelfrost wurde verneint.
- Die Fragen nach Fieber, Schüttelfrost und Nachtschweiß wurden verneint.

Vorerkrankungen / Medikamente

- Bei dem Patienten seien keine Vorerkrankungen bekannt und er nehme keine Medikamente regelmäßig ein. Er nehme lediglich *Ibuprofen, 400mg* bei Bedarf ein.
- Die Patientin leide seit 10 Jahren an arterieller Hypertonie. Daher nehme sie Ramipril, 3mg, 1 Mal täglich am Morgen / Mittag / Abend / bei Bedarf.
- Als / An Vorerkrankungen seien bei der Patientin *chronische Zystitis, Hyperthyreose sowie ein Glaukom* bekannt.
- In der Vorgeschichte findet sich (ein) schlecht kontrollierter Diabetes mellitus (*Nominativ - Subjekt)*. In der Vorgeschichte findet sich (eine) chronische Insomnie.
- Er leide an Herpes Zoster. Es sei mit … behandelt worden. (Behandlung abgeschlossen)
- Er leide an Herpes Zoster. Es werde mit … behandelt. (Behandlung *nicht* abgeschlossen)
- *Stichwortartig: arterielle Hypertonie seit 10 Jahren → Ramipril, 3 mg, 1-0-0*
- *Angabe von Häufigkeit:*
    - *2 Mal*
    - *2-mal*
    - *einmal, zweimal täglich…*

Vor-OPs

- Bei der Patientin seien bislang keine Operationen durchgeführt worden.
- Die Frage nach Vor-OPs wurde verneint.

- Der Patient habe vor 5 Jahren eine Appendektomie gehabt, die komplikationslos / ohne Komplikationen verlaufen sei.
- Die Patientin habe im Alter von 18 Jahren eine Tonsillektomie gehabt, in deren Folge es zu einer Sepsis / Infektion gekommen sei.
- Beim Patienten sei vor 5 Jahren eine Endoprothese implantiert / eingesetzt worden.

Allergien & Unverträglichkeiten

- Bei der Patientin seien keine Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt.
- Der Patient habe eine Allergie gegen Nüsse / Amoxicillin / Pflaster, die sich durch Exantheme / Rhinokonjunktivitis / Taubheitsgefühl im Mund äußere.

Noxen

- Der Patient sei Nichtraucher.
- Die Patientin rauche seit 5 Jahren 1 Packung täglich. Das entspricht 5 Packungsjahren.
- Der Patient habe 10 Jahre lang geraucht. Seit 5 Jahren sei er Nichtraucher.
- Der Patient trinke keinen Alkohol.
- Der Patient trinke regelmäßig ein Bier / ein Glas Wein / Schnaps am Abend.
- Der Patient sei Alkoholiker / alkoholabhängig (gewesen).
- Alkohol-, Tabak- und Drogenkonsum wurden verneint.

Familienanamnese

- Die Familienanamnese ergab keine Auffälligkeiten.
- Die Familienanamnese ergab eine chronische Zystitis bei der Mutter sowie arterielle Hypertonie beim Vater.
- Der Vater sei im Alter von 80 Jahren an Krebs / durch einen Unfall / infolge einer Pneumonie verstorben.
- Der Vater habe im Alter von 75 Jahren eine Bypass-Operation gehabt.

Sozialanamnese

- Die Patientin sei Steuerberaterin (von Beruf) / in Rente, verheiratet, lebe gemeinsam mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern.
- Sie sei Rechtsanwältin und habe viel Stress bei der Arbeit sowie im Privatleben.

Verdachtsdiagnose

- Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf *eine Appendizitis* hin.
- Die Wanderung der Schmerzen in den rechten Unterbauch verstärkt diesen Verdacht.
- Der hohe Tabak- und Alkoholkonsum sind bekannte Risikofaktoren, die die Verdachtsdiagnose unterstützen.

Differentialdiagnosen

- Differentialdiagnostisch kommen *Gastroenteritis, Pankreatitis, sowie Kolonkarzinom* in Betracht / infrage.

Nächste Schritte / Diagnostik

- Um die Verdachtsdiagnose zu bestätigen, schlage ich folgendes Vorgehen vor:
    - Körperliche Untersuchung (KU)

    - Laboruntersuchung (BB, CRP, …)
    - Koloskopie
    - …
- Zunächst werde ich die Patientin körperlich untersuchen, ihr Blut abnehmen für das Labor sowie ein EKG schreiben lassen / durchführen.
- Darüber hinaus sollten wir ein Röntgen des Thorax sowie eine Sonographie des Abdomen durchführen / veranlassen / beauftragen.
- Wir sollten weitere Untersuchungen durchführen, um *eine akute Pneumonie ausschließen* zu können.
- Im Labor sollten wir insbesondere die folgenden Werte *prüfen / überprüfen / kontrollieren*: …
- Zudem empfehle ich ein *kardiologisches* Konsil.

Therapie

- Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich folgendes Vorgehen vor:
    - stationäre Aufnahme
    - Analgetika
    - Appendektomie
- Der Patient sollte stationär aufgenommen werden.
- Ich empfehle die (intravenöse) Verabreichung von Analgetika / Sauerstoffgabe.
- Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, sollten wir schnellstmöglich eine *Appendektomie / Cholezystektomie* durchführen.
- Sollte sich der klinische Zustand verschlechtern, werden wir eine *Intensivüberwachung einleiten*.

Arzt-Arzt-Gespräch

Infos aus dem Gespräch / Allgemeine Fragen

- Häufig Sätze aus der Patientenvorstellung

Definition

- Eine Urolithiasis ist definiert als das Vorhandensein von Steinen in den Harnwegen.
- Eine Urolithiasis ist …
- Von einer Urolithiasis spricht man, wenn…
- Bei einer Urolithiasis handelt es sich um …
- Bei einer Urolithiasis finden sich…
- Es geht um einen Stein in der Blase oder dem Harnleiter.
- *Vergleich:* Im Gegensatz zum Schlaganfall dauern die Beschwerden bei einer TIA weniger als 20/30/60 Minuten.
- *Vergleich*: Zu unterscheiden ist das von einer Cholezystolithiasis, bei der der Gallenstein sich in der Gallenblase befindet.
- *Vergleich*: Bei einer Cholezystolithiasis befindet sich der Gallenstein in der Gallenblase. Bei einer Choledochlithiasis befindet sich der Gallenstein im Hauptgallengang.
- *Vergleich*: Bei einer Cholezystolithiasis befindet sich der Gallenstein in der Gallenblase, **wohingegen**/während sich bei einer Choledocholithiasis der Gallenstein im Hauptgallengang befindet.

Klassifikation

Die Klassifikation kann anhand von Schweregraden, Ätiologie, Lokalisation, Kompensation, Krankheitsverlauf, Pathophysiologie, Pathomechanismus … erfolgen.

- Bei einer pAVK werden die Stadien anhand der Schweregrade der Symptome definiert. Im ersten Grad… Der zweite Grad wird auf Basis der symptomfrei zu gehenden Wegstrecke weiter unterteilt.
- Ein Schädel-Hirn-Trauma kann in drei Grade eingeteilt werden: Der 1. Grad… Der 2. Grad… Und der 3. Grad…
- Bei einer Fraktur basiert die Klassifikation auf dem Schweregrad.

Risikofaktoren

- Eine TVT hat viele Risikofaktoren, zum Beispiel längere Immobilität, Nikotinkonsum, weibliches Geschlecht, hormonelle Verhütung, Herzinsuffizienz, Varizen, …
- Die Risikofaktoren für eine TVT beinhalten: …
- Als Risikofaktoren können … genannt werden.
- *Vergleich*: Längere Immobilität ist ein Risikofaktor für eine TVT, aber/jedoch nicht für eine pAVK.

Ätiologie

- Ein Schlaganfall kann zwei verschiedene Ursachen haben: eine Thrombose (ischämischer Schlaganfall) oder eine intrakranielle Blutung (hämorrhagischer Schlaganfall).
- Bei einem Schlaganfall kann es sich um einen ischämischen oder einen hämorrhagischen Schlaganfall handeln.
- Zwei Ätiologien können zum Schlaganfall führen: Thrombose oder Blutung
- Als Ätiologie des Schlaganfalls kann man Thrombose oder Blutung nennen.
- Bei einem Schlaganfall kommen zwei Ätiologien in Betracht.
- Eine TVT kann eine Lungenembolie zur Folge haben.
- *Vergleich*: Ein ischämischer Schlaganfall kann durch eine Thrombose verursacht werden, wohingegen ein hömorrhagischer Schlaganfall zum Beispiel durch eine Aneurysmaruptur verursacht werden kann.
- *Vergleich*: Ein ischämischer Schlaganfall wird durch eine Durchblutungsstörung des Gehirns ausgelöst, wohingegen ein hämorrhagischer Schlaganfall durch eine intrakranielle Blutung ausgelöst wird.
- *Vergleich*: Eine Arteriosklerose kann zu pAVK führen, wohingegen eine TVT zu einer Lungenembolie führen kann.

Symptomatik / Differentialdiagnosen

- Bei einer Divertikulitis kommen Symptome wie Bauchschmerzen im linken Unterbauch, Übelkeit und Fieber in Betracht.
- Eine Divertikulitis kann viele Symptome haben, zum Beispiel Unterbauchschmerzen auf der linken Seite, Übelkeit und Fieber.
- Eine Divertikulitis kann Symptome wie Bauchschmerzen im linken Unterbauch, Übelkeit und Fieber verursachen.
- Die typischen/häufigsten Symptome bei einer Divertikulitis sind Bauchschmerzen im linken Unterbauch, Übelkeit und Fieber.
- Eine Divertikulitis äußert sich häufig durch Symptome wie Unterbauchschmerzen auf der linken Seite, Übelkeit und Fieber.

- Eine Divertikulitis kann man an Symptomen wie … erkennen.
- *Vergleich*: Bei einer Pneumonie finden wir meist produktiven Husten, **wohingegen**/während wir bei Asthma bronchiale meist trockenen Husten vorfinden.
- *Vergleich*: Bei einer Divertikulitis finden wir die Schmerzen häufig auf der linken Seite, **wohingegen** bei Appendizitis die Schmerzen auf der rechten Seite sind.
- *Vergleich*: Im **Gegensatz** zu einer Divertikulitis sind die Unterbauchschmerzen bei einer Appendizitis meist rechts lokalisiert.
- *Vergleich*: Wenn es sich um eine *Appendizitis* handeln würde, würde ich zusätzlich *Druckschmerz am McBurney-Punkt* erwarten.

Komplikationen

- Bei einer TVT kann es zu einer Lungenembolie kommen.
- Eine TVT kann zu einer Lungenembolie führen.
- Eine TVT kann eine Lungenembolie verursachen/auslösen.
- Eine TVT kann der Auslöser/die Ursache für eine Lungenembolie sein.
- Im schlimmsten Fall kann es infolge einer TVT zu einer Lungenembolie kommen.
- *Vergleich*: Bei einer TVT kann es zu einer Lungenembolie kommen, **wohingegen** eine pAVK ein Gangrän verursachen kann.

Diagnostik

- Ich empfehle ein/e MRT des Ösophagos / der Halsregion, Blutabnahme zur Überprüfung auf Tumormarker sowie onkologisches Konsil.
- Ich empfehle, ein/e MRT des Ösophagos / der Halsregion, eine Blutabnahme zur Überprüfung auf Tumormarker sowie ein onkologisches Konsil durchzuführen.
- Der Goldstandard bei Verdacht auf Ösophaguskarzinom ist eine ÖGD. Zudem sollten … durchgeführt werden.
- Als Alternativen kommen … in Betracht.

Therapie

- Sollte der Verdacht (auf …) bestätigt werden, kommen … in Betracht.
- Ich würde … empfehlen.
- Allgemein kommen operative Therapie, medikamentöse Therapie, Strahlentherapie, palliative Therapie, sowie konservative Therapie in Betracht.
- (Asthma bronchiale): Zuerst könnten wir prüfen, ob eine konservative Therapie mit Atemübungen und Nikotinkarenz Besserung bringt. Außerdem kann der Patient einen Inhalator verwenden, um akute Asthmaanfälle zu lindern. Eine operative Therapie kommt bei Asthma bronchiale nicht in Betracht.
- *Vergleich*: Wenn es sich um einen ischämischen Schlaganfall handelt, dann kommt eine medikamentöse Therapie in Betracht, wohingegen bei einem hämorrhagischen Schlaganfall sofort eine Hämostase erfolgen muss. Zudem kann bei einer leichten Form eines hämorrhagischen Schlaganfalls eine konservative Therapie erwogen werden. Die korrekte Diagnose ist insbesondere daher wichtig, da die medikamentöse Therapie bei ischämischem Schlaganfall eine Kontraindikation bei einem hämorrhagischen Schlaganfall darstellt.

Kontraindikationen

- Der Verdacht auf Divertikulitis ist eine Kontraindikation für die Koloskopie.

- Bei Verdacht auf Divertikulitis ist eine Koloskopie kontraindiziert.
- Bei Verdacht auf Divertikulitis sollte in der akuten Entzündungsphase auf keinen Fall eine Koloskopie durchgeführt werden, da/weil ein Risiko für eine Kolonruptur besteht.

Aufklärungen

siehe Aufklärungen…

Fachbegriffe / Abkürzungen

- In Umgangssprache würde ich zu einer Pneumonie “Lungenentzündung” sagen
- Die Abkürzung EKG **steht für** Elektrokardiogramm.
- Bei Leukozyten **handelt es sich um** weiße Blutkörperchen.

Die “schlimmsten” Fehler

Schweigen / Stille, bei schwierigen Fragen

In der FSP wird euer medizinisches Wissen nicht geprüft. Wenn ihr medizinische Fragen gestellt bekommt, dann wollen die Prüfer sehen, dass ihr flüssig und fachsprachlich darauf antworten könnt. Wenn einzelne Punkte fachlich falsch sind, ist das okay.

Manchmal stellen sie mit Absicht schwierige Fragen, um zu prüfen, wie ihr in Stresssituationen reagiert. Auch bei schwierigen Fragen ist flüssiges Antworten daher sehr wichtig. Gerne könnt ihr auch sagen: “Es tut mir leid, da bin ich mir leider nicht sicher. Aber ich glaube, dass…” oder so ähnlich.

“Das habe ich nicht verstanden…”

Manchmal werdet ihr im Arzt-Arzt-Gespräch nach Details aus dem Anamnesegespräch gefragt. Daher ist es **sehr wichtig** alle Patientenaussagen in der Anamnese richtig zu verstehen, auch wenn diese im Gespräch nicht sehr wichtig erscheinen. Die Prüfer möchten euer Hörverständnis prüfen. Und sie merken es sofort, wenn ihr etwas nicht versteht und werden dann häufig danach fragen. Daher bittet den Patienten gerne, seine Aussage zu wiederholen oder nochmal neu zu formulieren.

Falsche Frage beantworten

Bitte achtet genau auf die Fragen der Prüfer. Wenn ihr z.B. nach Symptomen des Patienten gefragt werden, solltet ihr nicht allgemeine Symptome einer Erkrankung nennen. Wenn ihr nicht sicher seid, könnt ihr den Prüfer bitten, die Frage zu wiederholen oder anders zu formulieren.

Was ihr unbedingt vermeiden möchtet, ist dass ihr während der Antwort unterbrochen werdet, weil ihr die falsche Frage beantwortet.

Manche Fragen können auch sehr ähnlich sein. In diesem Fall: Lieber nachfragen! Zum Beispiel:

- Zu welchen Risiken kann es bei einer TVT kommen? → Lungenembolie
- Bei welchen Risikofaktoren kann es zu einer TVT kommen? → Immobilität, Herzinsuffizienz, …

Empathie & Reaktionen

Was bedeutet Empathie?

Patienten können im Arzt-Patienten-Gespräch eine Vielzahl von Emotionen zeigen. Diese Emotionen sind sowohl eine Chance als auch eine Herausforderung für Ärztinnen und Ärzte. Wenn du gut auf die Emotionen eines Patienten reagierst, kannst du sein volles Vertrauen gewinnen. Wenn du eine emotionale Reaktion ignorierst, kann es gut sein, dass der Patient sich unwohl fühlt und das Vertrauen verliert.

Die folgende 3-Schritt-Regel soll dir helfen, in der FSP - und auch im Berufsleben - immer angemessen auf Emotionen der Patienten zu reagieren:

1. Emotion “spiegeln”, bzw. auf die Emotion eingehen

   Ziel: Die Emotion des Patienten benennen und anerkennen. Der Patient fühlt sich gehört.

   Tipp: Je spezifischer die Reaktion ist, desto besser. Denn: “auswendig gelernte” Reaktionen und “Phrasen” schaffen kein Vertrauen - und langweilen auch die Prüfer

   Beispiele:

   - Es tut mir sehr leid, **dass Ihr Vater an Krebs leidet…**
   - Es tut mir sehr leid…
   - Ich verstehe Ihre Sorgen…
   - Es freut mich sehr, das zu hören…
   - Entschuldigen Sie bitte…
   - Herzlichen Glückwunsch…

2. Emotion “lösen”, bzw. allgemeiner Kommentar

   Ziel: Die Emotion des Patienten schwächen (negative) bzw. stärken (positive Emotionen).

   - Wir versuchen immer, Sie bestmöglich zu behandeln…
   - Die Wahrscheinlichkeit der Risiken ist sehr gering und ich führe diese Operation fast täglich durch.
   - Das muss wirklich schwer für Sie sein…
   - Es ist super, dass Sie jetzt nach so langem Warten doch auf natürlichem Weg schwanger geworden sind!

3. Auf das Gespräch zurückführen

   Ziel: Patienten von der Emotion “ablenken” und Gespräch weiterführen

   - Sind Ihre Kinder denn gesund?
   - Könnten Sie mir sagen, woran genau Ihr Vater verstorben ist?
   - Was genau bringt Sie denn heute zu uns?
   - Habe ich richtig verstanden, dass…

Was du vermeiden solltest…

Emotionslose Reaktionen

Patient: Meine Mutter ist letztes Jahr bei einem Autounfall um's Leben gekommen…

Arzt: *Okay*, und lebt ihr Vater noch?

Allgemeine Phrasen

Patient: Könnte es sein, dass ich Krebs habe?

Arzt: Bitte *malen Sie nicht direkt den Teufel an die Wand*. Man muss nicht immer an das Schlimmste denken.

Eskalation des Gesprächs

Patient: Ich musste jetzt schon zum dritten Mal etwas wiederholen, weil Sie mich nicht verstanden haben…!

Arzt: Bitte *beruhigen* Sie sich.

Patient: Ich möchte mich nicht beruhigen… Ich finde das unverschämt! □

"Wäscheleinen-Empathie"

Patient: Meine Mutter ist an Darmkrebs verstorben. Könnte es sein, dass ich auch Krebs habe?

→ Welche Emotion zeigt der Patient mit dieser Aussage?

Arzt: Es tut mir leid, das zu hören und mein herzliches Beileid. Denken Sie nicht an Krebs. Jetzt muss ich für die Anamnese weitere Fragen stellen und dann machen wir eine Untersuchung. Und dann können wir Schritt für Schritt für Ihre Beschwerden eine Lösung finden. Aber Sie sind in guten Händen, also machen Sie sich keine Angst.

Arzt (besser): Ich verstehe, dass Sie sich darüber Sorgen machen und mein herzliches Beileid wegen Ihrer Mutter. Ihre Beschwerden können viele verschiedene Ursachen haben und wir werden bald rausfinden, woran es liegt. Können Sie mir vielleicht beschreiben, wie Ihr Durchfall aussieht?

…, aber

Patient: Ich habe Sorgen vor der OP. Ich war noch nie in Vollnarkose.

Arzt: Ich verstehe Ihre Sorgen, *aber* Sie sind bei uns in guten Händen.

→ Das "aber" revidiert die vorige Aussage ("Es tut mir leid."). Als Ersatz kann häufig das Wort "gleichzeitig" verwendet werden. Selbe Bedeutung - ohne Widerspruch.

Frage zu "anderem Thema"

Arzt: Trinken Sie Alkohol?

Patient: Nein, meine Mutter war Alkoholikerin und ist leider bei einem Autounfall in alkoholisiertem Zustand um's Leben gekommen.

Arzt: Mein herzliches Beileid. Und rauchen Sie?

Häufige Emotionen in der FSP

Glück, Freude, Zufriedenheit

Ausdrücke des Patienten

Explizit	
Ich bin glücklich.	*glücklich (über etwas) sein*
Ich freue mich.	*sich über etwas freuen*
Ich bin (sehr) froh.	*froh über etwas sein*
Ich bin zufrieden.	*mit etwas zufrieden sein*
Implizit	
Ausrufe: “Super”, “Toll”, “Sehr schön”, “Fantastisch”, “Ausgezeichnet”, “Cool”, “Wunderbar”, “Prima”, “Wow”, “Spitze”, “Klasse”, “Wahnsinn” Ausrufe (umgangssprachlich): “Mega”, “Geil”, “Krass”, “Top”	
Die Behandlung war sehr gut und professionell.	
Die Diagnose war präzise.	
Das ging ja schnell!	
Meine Kinder sind das Allerwichtigste in meinem Leben!	
Gott sei Dank habe ich keine Erkrankungen…	
Zum Glück hat die Krankenversicherung alle Kosten übernommen.	

Ich hab's endlich geschafft mit dem Rauchen aufzuhören!	
Ich habe bei dem Eingriff fast gar nichts gespürt.	→ Super, dass Sie so wenig gespürt haben… Ich freue mich, dass es schmerzfrei war…

Reaktionen der Ärzte

Super… Wow…	
Herzlichen Glückwunsch!!	
Ich gratuliere Ihnen…	
Gott sei Dank…!	
Sie können wirklich stolz auf sich sein! Das ist gar nicht so einfach…	
Sehr schön…	
Wie schön…	
Vielen Dank, dass Sie das mit mir geteilt haben…	
Es ist schön, das zu wissen…	
Ich freue mich auch, …	
Es freut mich, dass Sie glücklich sind.	
Ich freue mich sehr für Sie.	*sich für jemanden freuen*

Dankbarkeit

Ausdrücke des Patienten

Explizit	
Ich bin Ihnen unendlich / für immer dankbar.	
Tausend Dank!	
Vielen herzlichen Dank…	
Herzlichen Dank…	
Vielen lieben Dank…	
Vielen Dank (für…).	
Dankeschön.	
Ich bin (Ihnen) dankbar.	
Danke sehr.	
Danke. (*transaktional*)	
Achtung: **Na**, danke… (ironisch) → Gegenteil von Dankbarkeit…	
Implizit	
Das ist lieb von Ihnen…	

Reaktionen der Ärzte

Jederzeit (gerne).	
Ich danke Ihnen. / Ich habe zu danken.	*Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen…*
Nichts zu danken…	
Gerne. Gern geschehen.	

Bitteschön.	
Kein Problem.	
Bitte.	

Angst, Nervosität, Sorge, Unsicherheit

Ausdrücke des Patienten

Explizit	
Ich fürchte mich.	*sich (vor etwas) fürchten (Angst)* *etwas befürchten (ich glaube, dass etwas schlechtes…)*
Ich habe Angst. Mir macht das Angst.	
Ich habe große Bedenken.	
Ich mache mir Sorgen. Ich habe Sorgen. Ich bin besorgt.	
Ich bin nervös.	
Ich bin unsicher. Ich fühle mich unsicher. Ich bin verunsichert.	
Implizit	
Sind Sie sicher?	
Und was wenn die Behandlung nicht wirkt?	

Kann das Krebs sein?	
Werde ich sterben?	
Ich habe meine Symptome gegoogelt…	
Dauert die Therapie lange?	
Was soll ich jetzt tun? Was können Sie für mich tun?	
Werde ich Schmerzen haben? Ist das schmerzhaft?	
Bitte, helfen Sie mir…!	
Gibt es Risiken?	
Muss ich mich in eine Röhre legen?	
Kann ich danach wieder ein normales Leben leben?	
Ausrufe: “Oh”, “Oh nein”, “Bitte nicht”, “Oh Gott”, “Oh man”, “Oh weh”, “Au weia”, “Um Gottes Willen”, “Scheiße”, “Scheibenkleister”, “Schade”	

Reaktionen der Ärzte

Ich verstehe. Ich verstehe, dass Sie Angst / Sorgen haben. Ich verstehe, dass Ihnen das Angst macht.	*Verständnis*
Ich glaube Ihnen…	*Verständnis*
Ich kann Ihre Angst / Sorgen sehr gut nachvollziehen.	*Verständnis*
Sie brauchen keine Sorge (zu) haben. Machen Sie sich keine Sorgen. Keine Sorge!	*Aufforderung / Ratschlag*

(Man muss nicht immer an das Schlimmste denken.)	*Aufforderung / Ratschlag*
Bei uns sind Sie in guten Händen. Wir machen das schon lang. Wir führen diese OP täglich durch und sind daher sehr erfahren. Ich mache diese OP jede Woche sehr häufig und es gibt fast nie Komplikationen…	*Beruhigung*
Sie können uns vertrauen. Sie können sich auf mich verlassen. Ich bin für Sie da. Ich kümmere mich darum.	*Beruhigung*
Wir schaffen das gemeinsam/zusammen. Sie schaffen das!	*Motivation*
Bleiben Sie bitte ruhig. Beruhigen Sie sich, bitte. Ich empfehle Ihnen, ruhig zu bleiben.	*Beruhigung / Aufforderung* *ggf. konfrontativ*

Traurigkeit, Depression

Ausdrücke des Patienten

Explizit	
Ich bin traurig.	
Ich bin deprimiert.	
Implizit	
weinen, Mimik	
Ich weine den ganzen Tag (ohne Grund).	

Ich habe keine Kraft / Lust. Ich kann nicht mehr…	
Ich habe das Gefühl, seit Wochen *müde* zu sein.	
Ich fühle mich antriebslos / allein / unmotiviert / “müde vom Leben” / gelangweilt.	
Ich bin zurückgezogener geworden…	
Ich habe keinen Appetit mehr…	
Ich glaube, diese Behandlung wird sowieso nichts bringen… (*hoffnungslos*)	
Mir macht nichts mehr Spaß / Freude…	
Ich bin am Boden (zerstört). Ich bin erschüttert.	
Ich finde keine Lösung / keinen Ausweg.	
Keiner versteht mich. Niemand bemerkt mich. Keiner weiß, wie sich das anfühlt.	
Das Leben hat keinen Sinn mehr… Ich will mich umbringen…	
Ich glaube, ich brauche ein bisschen Zeit, das zu verarbeiten…	
Diese Nachrichten muss ich erstmal verdauen….	
Patient berichtet über: Verlust, Enttäuschung, Probleme bei der Arbeit, Streit mit dem Partner, Krankheit, …	
Arten und Weisen “Verlust / Tod” auszudrücken: • Mein Partner ist verstorben… • Meine Partnerin ist tot… • Ich habe meine Mutter verloren… • Ich bin verwitwet… • Mein Hund ist nicht mehr unter uns… • Meine Katze ist im Himmel… • Mein Vater ist nun an einem besseren Ort…	

• Mein Sohn ist nicht mehr in/auf dieser Welt… • Meine Oma hat das Zeitliche gesegnet… • Mein Freund hat den Löffel abgegeben… • *draufgehen, abkratzen*	

Reaktionen der Ärzte

Ich verstehe Ihr Gefühl…	
Ich kann Ihr Gefühl (diese Situation) nachvollziehen.	
Es tut mir leid.	
Es tut mir leid, das zu hören…	
Das klingt sehr belastend.	
Danke, dass Sie mir das anvertraut haben.	
Mein (herzliches) Beileid.	*(fast) nur bei Todesfällen* *5 Phasen der Trauer*
Sie haben mein Mitgefühl.	
Das ist ja schrecklich / fürchterlich!	
zuhören	
Möchten Sie mehr darüber sprechen?	
Schade…	*"Ich bin enttäuscht…"* *nicht zu empfehlen, da es sehr ironisch klingen kann…* *Nur verwenden, wenn das Thema der anderen Person **nicht** wichtig ist.*

Genervt, Ungeduld, Bosheit, Wut, Zorn

Ausdrücke des Patienten

Explizit	
Ich bin wütend. Ich koche vor Wut. Ich bin wütend **auf… (Akk.)**	
Ich bin zornig.	
Ich bin sauer. Ich bin stinksauer. Ich bin sauer **auf… (Akk.)**	
Ich bin verärgert. Das ärgert mich. Ich bin verärgert **von… (Dativ)**	
Ich bin frustriert. Das frustriert mich. Ich bin frustriert **von… (Dativ)**	
Ich bin genervt. Ich bin genervt **von… (Dativ)** Das nervt mich…	*Ich hab die Nase voll.*
Ich bin böse. Das macht mich böse. Ich bin böse **auf… (Akk.)**	
Ich hab keine Lust / keinen Bock mehr.	*Achtung: kontextabhängig ob Traurigkeit oder Wut*

Ich finde das inakzeptabel / unerhört / unverschämt / unmöglich!	
Ich verliere die Geduld...	
Ich möchte mich nicht beruhigen!	
Implizit	
Ich möchte jemanden schlagen…	
Ich warte seit 3 Stunden…	
Warum dauert das so lange?	
Ich habe das schon mehrmals wiederholt.	
Hören Sie mir nicht zu?	
Was wissen Sie eigentlich?	
Gibt es keine andere Möglichkeit?	
Können Sie sich beeilen?	
Warum passiert das immer mir?	
Keiner nimmt mich ernst…	
Verstehen Sie das wirklich? Haben Sie auch Ihre Kinder verloren?	
Ich will wissen, was mit mir los ist!	
Sagen Sie nichts…	

Reaktionen der Ärzte

Es ist gut, dass Sie darüber sprechen.	*Verständnis / bedanken*

Ich verstehe, dass Sie (darüber / deshalb) zornig / wütend / … sind. Ich verstehe Ihren Zorn / Ihre Wut /…	*Verständnis*
Ja, das ist echt nervig!	*Verständnis*
Es tut mir leid, dass… • Sie so lange warten mussten • ich Sie erneut darum bitten muss, das zu wiederholen • ich Ihnen keine andere Option vorschlagen kann.	*entschuldigen*
Lassen Sie Ihre Wut ruhig raus..	
Lassen Sie uns ruhig darüber sprechen.	
Ich werde versuchen, Sie zu unterstützen…	
nichts sagen	
Beruhigen Sie sich bitte ein bisschen..	*Achtung!*
Ich werde Ihnen gerne alles Schritt für Schritt erklären.	
Ich werde mich beeilen.	

Scham, Peinlichkeit

Ausdrücke des Patienten

Explizit	
Ich **schäme** mich *dafür*. Ich schäme mich, darüber zu sprechen. Ich habe Scham…	*sich für etwas schämen*
Das ist mir **peinlich**.	

Es ist mir peinlich, offen darüber zu reden.	
Das ist mir **unangenehm**. Es ist mir unangenehm, …	
Ich möchte **nicht** / **ungern** darüber **sprechen**.	
Ich fühle mich **unwohl**, diese Information mit Ihnen zu teilen.	
	Häufig auf Fragen nach: • *Noxen / Drogenkonsum* • *Sexualanamnese* • *Gynäkologische Anamnese* • *Intimbereich* • *Familienstand (geschieden, …)* • *Familienanamnese (unbekannte Elternteile, Lebensgewohnheiten, …)* • *Psychische Erkrankungen, Suizidgedanken, traumatische Erlebnisse in der Vergangenheit* • *bestimmte Erkrankungen (STD, Pilze, HIV, …)* • *(Beruf, Alter, Gewicht, …)* • *Körperliche Untersuchung ("Bitte legen Sie Ihre Kleidung ab. Bitte machen Sie Ihren Oberkörper frei.")* • *Stuhlgang, Urin*
Implizit	
Ich habe lange gewartet, zum Arzt zu gehen.	
Ist das wirklich wichtig / notwendig für die Diagnose?	
Das weiß ich nicht. (Ich kenne	

mein Gewicht nicht.)	
Müssen Sie das wirklich wissen?	
Muss das wirklich sein?	
ausweichen*, *Blick auf den Boden*, *Blickkontakt vermeiden	
Ablenken / anderes Thema: Ah, ich wollte Ihnen noch sagen, dass…	
Falschaussage: Nein / Ja …	*sehr schwer, rauszuhören*

Reaktionen der Ärzte

Ich verstehe, dass Sie diese Frage unangenehm finden…	
Ich verstehe, dass diese Frage etwas unangenehm sein kann.	
Ich verstehe, dass es etwas peinlich sein kann, darüber zu sprechen…	
Nach Themawechsel: Ich möchte jetzt trotzdem nochmal kurz zurück zu meiner vorigen Frage kommen…	
Warum?: Es ist wichtig, diese Informationen zu kennen, um eine korrekte Diagnose stellen zu können.	
Sie können mir vertrauen.	*Vertrauen aufbauen*
Diese Informationen bleiben natürlich unter uns, sie ***unterliegen*** der ärztlichen Schweigepflicht.	*Schweigepflicht ist ein rechtliches Thema (KP), gilt nicht immer 100%. Ausnahmen bspw.:* • *Verdacht auf Kindesmisshandlung* • *Gefahr für sich selbst oder für andere*

	• …

Skepsis, Ungläubigkeit, Zweifel, Unsicherheit

Ausdrücke des Patienten

Explizit	
Ich bin **skeptisch**.	*skeptisch gegenüber etwas sein*
Ich **glaube** das nicht. Ich glaube nicht daran.	***an** etwas glauben*
Ich habe **Zweifel**. Ich zweifle daran.	*Zweifel **an** etwas haben*
Ich bin mir **unsicher**. Ich bin mir nicht sicher.	
Achtung: Ich fühle mich unglaublich nach dieser Diagnose.	*sehr positive Emotion*
Implizit	
Das kann nicht (wahr) sein! Das ist unmöglich!	
Was für ein Quatsch!	
Was wissen Sie schon!	
Ich glaube, Sie haben da was verwechselt! Da muss eine Verwechslung vorliegen…	
Gibt es dafür einen Beweis?	
Wirklich? Echt? Was?	

Ist das wirklich notwendig?	
Sind Sie sicher?	
Damit habe ich nicht gerechnet…	
Vielleicht haben Sie einen Fehler gemacht?	
Herr Doktor, Sie haben doch keine Ahnung!	
Ich habe im Internet etwas anderes gesehen.	
Frau Doktor, haben Sie eigentlich wirklich studiert?	
Machen Sie Späße? Machen Sie einen Witz?	

Reaktionen der Ärzte

Erste Reaktion	
Ich verstehe, dass diese Nachricht schrecklich ist…	
Es tut mir leid, dass Sie diese Diagnose erhalten mussten…	
Es ist für viele Patienten schwierig, das zu hören…	
Du bist dir sicher!	
Ja! Ja, leider… (Nein, …) Doch! Bestimmt!	
Daran besteht kein Zweifel! Daran gibt es keine Zweifel!	

Ich bin mir zu 100% sicher. Ich bin mir sehr sicher.	
Sie können mir vertrauen.	
Die Untersuchungsergebnisse waren eindeutig!	
Ich kann Ihnen das gerne Schritt für Schritt erklären.	
Wir können uns gerne gemeinsam die Untersuchungsergebnisse anschauen und ich erkläre Ihnen alles.	
Du bist unsicher	
Wir sollten noch weitere Untersuchungen durchführen, um ganz sicher zu sein!	
Ich bin mir noch nicht 100% sicher, aber es sieht danach aus.	
Zum jetzigen Zeitpunkt können wir das noch nicht mit Sicherheit sagen.	
Ich denke schon…	
Hm, gute Frage…	
Das glaube ich…	

Leid (emotional, körperlich), Schmerzen, Stress

Ausdrücke des Patienten

Explizit / Implizit	
Ich habe Schmerzen.	
Ich leide an / unter…	
Ich bin total erschöpft.	

Ich bin krank.	
Ich habe keine Kraft mehr.	
Mir geht es nicht gut…	
Ich habe Stress.	
Meine Arbeit ist sehr anstrengend.	
Ich schlafe kaum…	

Reaktionen der Ärzte

Leichte Reaktionen	
Was haben Sie denn?	
Können Sie das bitte etwas mehr beschreiben?	
Okay, danke für die Info…	
Stärkere Reaktionen	
Das tut mir leid zu hören…	
Es ist sehr gut, dass Sie zu uns gekommen sind.	
Sie sind in guten Händen. (Machen Sie sich keine Sorgen…)	
Oh, das sind wirklich sehr starke Schmerzen…	
Können Sie die Schmerzen gerade ertragen? Oder möchten Sie gerne ein Schmerzmittel (etwas gegen die Schmerzen)	1. Allergien abfragen 2. Schmerzmittelnahme abfragen 3. Schmerzmittel “anbieten”

bekommen?	4. Über Form der Verabreichung aufklären 5. Zustimmung / Einverständnis einholen 6. ggf. **Notfall** ausschließen Können Sie die Schmerzen noch bis zum Ende des Gesprächs ertragen/aushalten? Haben Sie bereits Schmerzmittel wegen der Schmerzen eingenommen? Wenn ja, welche? Sind bei Ihnen Allergien gegen Medikamente bekannt? Okay, dann können wir Ihnen jetzt gerne ein Schmerzmittel verabreichen. Wir werden dazu einen Zugang legen, damit das Schmerzmittel noch schneller wirkt. *Schmerzen im "Mittelfeld":* Es wäre besser, wenn wir Ihnen das Schmerzmittel erst nach der körperlichen Untersuchung verabreichen. Wenn Sie die Schmerzen aber nicht ertragen können, dann geben wir es Ihnen auch jetzt direkt.
Bekommen Sie denn jetzt gerade ausreichend Luft? Ansonsten können wir Ihnen Sauerstoff geben..	